

Buku Ajar

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN

Maryana • Ikawati setyaningrum • Achmad Rizki Azhari
Patria Asda • Rizeki Dwi Fibriansari
Sarti Oktarina Purba



BUKU AJAR: KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN

Penulis:

Ns. Maryana, M.Kep.

Ikawati setyaningrum, M.Kep.

Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Patria Asda, S.Kep, Ns., M.P.H.

Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Sarti Oktarina Purba, S.Kep., M.Kep.

Buku Ajar: Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan

Penulis: Ns. Maryana, M.Kep.

Ikawati setyaningrum, M.Kep.

Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Patria Asda, S.Kep, Ns., M.P.H.

Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Sarti Oktarina Purba, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-96049-2-5

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar "Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan" ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada mahasiswa keperawatan, praktisi keperawatan, serta para pemimpin dan manajer pelayanan kesehatan dalam memahami peran strategis mereka di lingkungan klinis yang kompleks.

Buku ajar ini disusun berdasarkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen di dunia keperawatan, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar kepemimpinan dan fungsi manajerial dalam praktik keperawatan, hingga aplikasi praktis pengaturan alur kerja dan adaptasi intrapersonal bagi tenaga keperawatan yang menghadapi burnout di era pandemi.

Pembahasan buku ini terdiri dari enam bagian utama, yaitu kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan; manajemen dan pengaturan alur kerja dalam penanganan pasien COVID-19; adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menghadapi burnout; fungsi pengarahan dalam praktik keperawatan; pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan; serta konferensi dan timbang terima sesuai konsep manajemen yang berlaku. Setiap topik disusun secara sistematis, dilengkapi dengan teori terbaru dan praktik terbaik berbasis bukti untuk menjamin relevansi dan aplikabilitas dalam konteks klinis.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi utama yang mendukung pengembangan profesionalisme, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan manajerial yang dihadapi oleh tenaga keperawatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, khususnya kepada para akademisi, praktisi, serta institusi pendidikan keperawatan yang turut memberikan kontribusi berharga.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ilmu keperawatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta mampu mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin keperawatan yang unggul dan berdedikasi tinggi.

Juni, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KEPEMIMPINAN, PERAN, DAN FUNGSI MANAJEMEN

KEPERAWATAN	1
A. Pemimpin dan Kepemimpinan serta Berbagai Gaya Kepemimpinan.....	3
B. Konsep Manajemen Keperawatan.....	12
C. Fungsi Manajemen Keperawatan	13
D. Tingkatan Manajer Keperawatan	22
E. Peran Manajer	24
F. Latihan Soal	26
G. Rangkuman Materi.....	26
H. Daftar Pustaka	26

BAB 2 MANAJEMEN DAN PENGATURAN ALUR KERJA DALAM

PELAKSANAAN PENANGANAN PASIEN COVID-19	29
A. Prinsip Dasar Manajemen Alur Kerja dalam Penanganan Pasien COVID-19...	30
B. Pengelolaan Proses Kerja Tim Keperawatan	31
C. Evaluasi Efektivitas Pengaturan Alur Kerja	33
D. Strategi Praktis dan Implementasi	34
E. Latihan Soal	36
F. Rangkuman Materi	38
G. Glosarium	39
H. Daftar Pustaka	40

BAB 3 ADAPTASI INTRAPERSONAL DAN MENGELOLA EMOSI DALAM

MENANGANI BURNOUT UNTUK PASIEN COVID-19	43
A. Adaptasi Intrapersonal.....	44
B. Mengelola Emosi dalam Menangani Burnout.....	45
C. Implementasi Strategi Adaptasi dan Pengelolaan Emosi	47
D. Latihan Soal	48
E. Rangkuman latihan	50
F. Glosarium	51
G. Daftar Pustaka	52

BAB 4 FUNGSI PENGARAHAN

A. Definisi Pengarahan	57
B. Tujuan Fungsi Pengarahan.....	57

C. Pentingnya pengarahan dalam manajemen keperawatan.....	57
D. Komponen Pengarahan.....	57
E. Jenis – Jenis Pengarahan.....	58
F. Metode Pengarahan	58
G. Tantangan dalam pengarahan.....	58
H. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengarahan.....	59
I. Prinsip pengarahan Efektif	59
J. Latihan Soal.....	59
K. Rangkuman Materi.....	59
L. Glosarium	60
M. Daftar Pustaka	60

BAB 5 PENGENDALIAN MUTU ASUHAN DAN PELAYANAN

KEPERAWATAN	61
A. Pengertian Penjaminan Mutu Pelayanan Keperawatan	62
B. Fungsi dan Proses Sistem Pengendalian Mutu.....	63
C. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan	65
A. Instrumen dan Metode Pengendalian Mutu Keperawatan.....	66
B. Prinsip Manajemen Mutu Terpadu	68
C. Indikator Mutu Keperawatan.....	70
D. Latihan Soal	71
E. Kunci Jawaban.....	74
F. Rangkuman Materi.....	74
G. Glosarium	75
H. Daftar Pustaka	76

BAB 6 KONFERENSI DAN TIMBANG TERIMA SESUAI KONSEP

MANAJEMEN.....	79
A. Defisini Konferensi	81
B. Tujuan Konferensi (Suarli, 2012). (Silvia Nur, 2024).....	81
C. Pedoman Pelaksanaan Konferensi	81
D. <i>Pre dan Post Conference</i>	82
E. Tujuan <i>Pre Conference</i>	82
F. Tujuan <i>Post Conference</i> (Nursalam, 2014)	82
G. Persyaratan dalam pelaksanaan <i>Pre dan Post Conference</i> yaitu :	83
H. Definisi Timbang Terima	83
I. Tujuan Timbang Terima.....	83
J. Manfaat Timbang Terima (NHS, 2008)	84
K. Prinsip Timbang Terima.....	84
L. Langkah-langkah pelaksanaan timbang terima (Nursalam, 2014)	85
M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbang Terima	85
N. Jenis Timbang Terima.....	85

O. Metode Timbang terima : SBAR (Buechel Cat, 2024)	86
P. Lima tips teknik timbang terima	87
Q. Proses timbang terima di samping tempat tidur pasien (Chaboyer, 2008)	88
R. Dokumentasi Dalam timbang terima.....	88
S. Latihan Soal.....	89
T. Kunci Jawaban.....	90
U. Rangkuman Materi	91
V. Glosarium	91
W. Daftar Pustaka	91
PROFIL PENULIS	93

BAB 1

KEPEMIMPINAN, PERAN, DAN FUNGSI MANAJEMEN KEPERAWATAN

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep pemimpin dan kepemimpinan serta berbagai gaya kepemimpinan
- Menjelaskan konsep Manajemen Keperawatan
- Menjelaskan peran manajemen keperawatan
- Menjelaskan fungsi-fungsi manajemen keperawatan

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran pada Bab ini adalah mahasiswa Mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan/ manajemen asuhan keperawatan

Pendahuluan:

Pendahuluan dalam sebuah buku ajar adalah bagian yang penting karena memberikan gambaran umum tentang isi buku tersebut serta tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam pendahuluan sebuah buku ajar:

- Judul: Judul buku yang mencerminkan tema atau topik utama yang akan dibahas.
- Pengantar Penulis: Sebuah pengenalan singkat dari penulis buku yang menjelaskan latar belakang dan kredensial mereka dalam topik yang dibahas.
- Tujuan Buku: Penjelasan tentang tujuan dari buku tersebut, apa yang ingin dicapai oleh pembaca setelah membaca buku tersebut.
- Sasaran Pembaca: Deskripsi mengenai siapa yang diharapkan akan menggunakan buku tersebut, misalnya, siswa sekolah menengah, mahasiswa, atau profesional.
- Isi Buku: Gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam buku, termasuk struktur, bab-bab, dan topik-topik utama yang akan disentuh.
- Metode Pembelajaran: Penjelasan tentang bagaimana buku ini dirancang untuk membantu pembaca belajar, apakah melalui teks tulisan, gambar, latihan, atau sumber daya tambahan.

- Pendekatan Pembelajaran: Penjelasan tentang pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan dalam buku tersebut, apakah itu pembelajaran aktif, pembelajaran kolaboratif, atau metode lainnya.
- Pedoman Penggunaan: Petunjuk tentang bagaimana pembaca sebaiknya menggunakan buku ini, mungkin termasuk saran tentang cara membaca secara efektif, bagaimana menangani latihan-latihan, atau cara memanfaatkan sumber daya tambahan.
- Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang jelas tentang apa yang bisa mereka harapkan dari buku tersebut dan bagaimana mereka dapat menggunakan buku tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran mereka.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik atau subjek tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Materi tersebut dapat mencakup konsep, teori, prinsip, fakta, contoh, dan aplikasi dari subjek yang dibahas. Uraian materi dalam buku ajar biasanya disesuaikan dengan target audiens dan tujuan pembelajaran, serta disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan terorganisir sehingga pembaca dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

A. Pemimpin dan Kepemimpinan serta Berbagai Gaya Kepemimpinan

1. Definisi Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan dua hal yang sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Apa itu pemimpin? Secara singkat pemimpin adalah orang yang ditunjuk sebagai kepala/ketua dalam suatu organisasi. Besar kecilnya area yang dipimpin tergantung pada level organisasinya. Pemimpin umumnya bersifat formal, resmi, dan mendapat Surat pengangkatan dari instansi terkait. Seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk dapat menjalankan tugas-tugas manajerial dalam mencapai Visi dan Misi dari suatu organisasi. Karna pemimpin menjadi sebuah “motor” yang akan membawa organisasi dapat berfungsi atau tidak. Dapat berjalan atau tidaknya. Pemimpin dibaratkan seperti sebuah lokomotif kereta api, dan anggotanya adalah gerbong-gerbong di belakangnya. Gerbong kereta tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa digerakkan oleh lokomotif. Seperti itulah perumpamaannya. Dengan demikian, pemimpin dalam suatu organisasi sangat besar perannya dalam perkembangan dan kemajuan suatu organisasi termasuk pelayanan keperawatan. Pemimpin, dalam istilah lainnya yaitu Leader (Inggris).

Lalu bagaimana dengan kepemimpinan? Dalam istilah lain yaitu leadership. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Setiawan (2015) kepemimpinan adalah daya upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber atau alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Almahmoud (2017) mengemukakan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai proses dimana seseorang mempengaruhi sekelompok individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat lain oleh Robbins (2017) kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian. Berdasarkan tiga pendapat para ahli dapat disimpulkan kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggerakkan oranglain agar dapat bekerja

sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan bersama.

Apa bedanya dengan pemimpin? Jika tadi disebutkan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang menduduki suatu jabatan, posisi, yang mengepalai suatu organisasi. Pemimpin dipilih dan mendapat surat pengangkatannya. Sedangkan kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain, atau dengan kata lain kemampuan seseorang menggerakkan orang lain untuk bekerja. Seorang pemimpin harus punya daya menggerakkan anggota atau anggotanya agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik.

Kalau tadi disebutkan pemimpin laksana lokomotif, maka kepemimpinan laksana mesinnya. Kemampuan menggerakkan orang lain tentu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena anggota kita memiliki karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda dan kemauan yang berbeda pula. Semakin banyak jumlah anggota atau anggota yang ada, maka semakin besar kemampuan “menggerakkannya”. Ini yang lebih sulit. Semakin banyak jumlah anggota, semakin bervariasi pula karakternya dan juga kemauannya. Ada anggota yang disiplin, ada juga yang sering telat, ada yang rajin, ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya lambat, ada yang teliti ada yang kurang teliti, ada yang baperan ada juga yang cuek bebek, ada yang suka protes tapi kinerja kurang. Akan banyak karakter dari orang di lingkungan kerja. Maka dari itu, seorang pemimpin hendaknya mengenali karakter setiap anggotanya, dan dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. Agar apa? Agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tugasnya, bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan visi dan misi yang ada, apapun karakter dari anggota kita. Sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada kemampuan pemimpinnya untuk menumbuhkan iklim kerja sama dalam menggerakkan sumber daya yang ada sehingga dapat mendayagunakannya dalam berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Almahmoud (2017) Kepemimpinan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk budaya organisasi, dan untuk memastikan bahwa perilaku, strategi, dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan dikembangkan.

2. Teori Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian Feriantina, dkk (2025) Teori kepemimpinan terbagi menjadi dua yaitu tradisional dan modern. Kepemimpinan tradisional dan modern memainkan peran penting dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kepemimpinan tradisional membawa stabilitas dan harmoni, sementara kepemimpinan modern menekankan adaptasi dan inovasi

Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan melalui pewaris-pewaris dalam suatu kelompok sosial. Pemimpin tradisional lahir karena diminta oleh masyarakat berdasarkan prestasi spritualitas dan amal baktinya kepada masyarakat. Kepemimpinan tradisional dibagi menjadi 3 teori yaitu :

a. Teori sifat

Teori sifat dalam kepemimpinan, atau Trait Theory, berargumen bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan yang membedakan mereka dari non-pemimpin. Sifat-sifat seperti kecerdasan, keberanian, dan karisma dianggap penting untuk efektivitas kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin dan nilai-nilainya lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik.

Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin

b. Teori behavioral

Teori perilaku atau *Behavioral Theories* ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap, bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari

c. Teori situasional

Teori kepemimpinan situasional adalah sebuah teori yang memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, menekankan pentingnya memahami situasi dan kondisi tim dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Ada beragam teori terkait kepemimpinan situasional. Diantaranya menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (1969). Kepemimpinan situasional diartikan sebagai teori kepemimpinan yang berfokus pada pengikut. Kepemimpinan yang efektif bisa dilihat dari relevansi tugas dan mungkin semua pemimpin yang berhasil selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang benar atau tepat. Pendekatan situasional ini berfokus pada kejadian kepemimpinan dalam situasi yang unik. Pada teori pendekatan situasional ini menjelaskan bahwa

kepemimpinan yang efektif dilihat dari bagaimana seorang pemimpin mengetahui kemampuannya, keadaan, dan sifat anggotanya.

Kepemimpinan Modern

Kepemimpinan Modern dikenal sebagai fase kepemimpinan di era serba teknologi, informasi, dan komunikasi ini. Kepemimpinan pada era ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan mempengaruhi namun juga keterampilan menggerakkan orang lain atau anggota. Kepemimpinan Modern adalah konsep yang dinamis dan terus berkembang, didorong oleh empati, pola pikir berkembang, dan rasa memiliki tujuan. Pemimpin yang memprioritaskan prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, memberdayakan tim mereka untuk unggul dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Seiring dengan terus berubahnya lanskap bisnis, pentingnya prinsip-prinsip kepemimpinan modern akan terus tumbuh, membentuk dunia kerja yang lebih kolaboratif, berempati, dan berorientasi pada tujuan. Konsep awal tentang kepemimpinan modern adalah seni dan ilmu guna mempengaruhi serta menggerakkan orang lain dalam suatu kelompok untuk melaksanakan cita-cita, tugas, dan tujuan dari suatu organisasi. Kepemimpinan modern terbagi menjadi beberapa teori. Berikut teori- teorinya:

a. Teori kepemimpinan karismatik

Kepemimpinan karismatik adalah bentuk kepemimpinan yang dikenal karena daya tarik pribadi yang dimiliki oleh pemimpinnya. Kepemimpinan ini menggabungkan kepribadian pemimpin yang menarik dan visi yang kuat dari pemimpinnya. Seorang pemimpin karismatik dapat memengaruhi dan memotivasi anggota timnya melalui pesona yang unik dan gagasan yang menginspirasi. Yang membedakan kepemimpinan karismatik dari gaya kepemimpinan lainnya adalah kemampuan mereka untuk memimpin dengan memanfaatkan daya tarik pribadi. Mereka membuat orang merasa terhubung dengan visinya serta mendorong semangat kerja tinggi dan menciptakan lingkungan di mana anggotanya termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kepemimpinan ini merupakan kombinasi dari karakteristik kepribadian, keterampilan komunikasi, dan visi yang bisa dikembangkan melalui latihan dan pengalaman

b. Teori kepemimpinan transaksional dan transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan suatu bentuk gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada upaya menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi maksimal dari setiap anggota tim. Bukan hanya sekedar memberikan arahan atau instruksi, pemimpin yang mengadopsi gaya

ini berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif yang mendalam, bukan hanya dalam dinamika tim mereka, tetapi juga dalam seluruh struktur organisasi. Sedangkan Kepemimpinan transaksional hakikatnya menyatakan dengan tegas seorang pemimpin harus memutuskan apa yang harus dilakukan oleh anggota tim untuk meraih suatu tujuan organisasi. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan melakukan transaksi guna mengarahkan maupun memotivasi pada anggota dengan menyerukan kepentingan mereka. Kepemimpinan ini cenderung fokus pada hal-hal terperinci. Para pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transaksional ini amat mengandalkan sistem pemberian penghargaan serta hukuman pada para anggotanya.

c. Kepemimpinan otentik

Kepemimpinan autentik adalah jenis gaya manajemen di mana orang bertindak dengan cara yang nyata, tulus, dan jujur yang sesuai dengan jati diri mereka sebagai individu.

d. Kepemimpinan terdistribusi

Kepemimpinan terdistribusi adalah kepemimpinan atau manajemen bersama. Kepemimpinan ini berfokus pada kepemimpinan kolektif dan menyeluruh, bukan pada peran dan tanggung jawab kepemimpinan tertentu.

e. Kepemimpinan digital

Digital leadership adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, mengelola, dan mempengaruhi organisasi dalam konteks dunia digital. Digital leadership bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam visi, strategi, dan operasional bisnis. Seorang digital leader tidak hanya mengadopsi teknologi terkini, tetapi juga memiliki visi strategis yang memungkinkannya untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif.

3. Tujuh Sifat Kepemimpinan yang Efektif

Seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin menggerak seseorang untuk bekerja. Terkait hal tersebut terdapat tujuh sifat yang dapat digunakan seorang pemimpin untuk dapat menggerakkan anggota secara efektif yaitu:

- a. Penggerak (drive). Seorang pemimpin menunjukkan tingkat usaha yang tinggi di hadapan anggotanya. Memiliki semangat yang tinggi untuk berhasil, ambisius, memiliki banyak energi, tidak kenal lelah dalam aktifitasnya, dan menunjukkan inisiatif. Karena ini secara tidak langsung akan menular ke anggotanya. Pemimpin yang semangat, anggota pun akan bersemangat,

begitupun sebaliknya. Jadi penting seorang pemimpin memiliki semangat yang tinggi dan sikap optimis dalam bekerja.

- b. Hasrat untuk memimpin (desire to lead). Pemimpin memiliki hasrat yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Mereka menunjukkan kemauan untuk menerima tanggung jawab. Dapat memberikan solusi dan jalan keluar ketika anggota mengalami masalah dan kesulitan. Dan pemimpin yang menghargai hasil dan kerja keras dari anggitanya.
- c. Kejujuran dan integritas (honesty and integrity). Pemimpin membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya dengan cara jujur dan tidak berkhianat, dan dengan menjaga konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. Kejujuran dari pemimpin akan menimbulkan respek dan loyalitas dari anggota, selain itu kejujuran dari pemimpin juga menumbuhkan rasa saling memiliki di lingkungan bekerja, sikap ingin mengembangkan organisasi karena sudah memiliki rasa keterikatan.
- d. Kepercayaan diri (self confidence). Pengikut pencari pemimpin yang tidak ragu-ragu. Dengan demikian, para pemimpin harus dapat menunjukan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan dan tujuan yang harus dicapai.
- e. Kecerdasan (intelligence). Pemimpin harus cukup cerdas agar dapat mengumpulkan, menyatukan dan menafsirkan banyak informasi, dan mereka harus dapat menciptakan visi, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan (job-relevant knowledge). Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. Dengan pengetahuan yang mendalam, pemimpin dapat membuat keputusan terbaik dan memahami implikasi keputusan tersebut. Pemimpin yang efektif membutuhkan keterampilan teknis, relasional, dan konseptual
- f. Extraversion. Pemimpin adalah orang yang energik dan penuh semangat. Suka bergaul, tegas dan jarang sekali berdiam diri atau menarik diri.

4. Gaya Kepemimpinan

Kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya menjadi bervariasi dan mengarah kepada gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Ada beberapa definisi gaya kepemimpinan menurut para ahli, diantaranya menurut Thoha yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Ermaya berpendapat gaya kepemimpinan itu berupa bentuk mengendalikan anggota untuk melaksanakan sesuatu. Menurut pendapat lain yaitu Hersey & Blanchard menyatakan gaya kepemimpinan

merupakan pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam rangka bekerja dengan dan melalui orang lain.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah "suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Umumnya gaya kepemimpinan hanya dikenal dalam dua gaya yaitu gaya otoriter dan gaya demokrasi. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas- tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokrasi dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Karakter dari setiap anggota bisa berbeda, begitu pula dengan situasi kondisi dan lingkungan dalam bekerja. Maka dari itu Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus disesuaikan dengan karakter-karakter tingkat kemampuan dalam tugas setiap bawahannya. Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya (Isnaeni, 2017).

Gaya kepemimpinan diibaratkan seperti mata pisau. Berbeda bentuknya, tergantung bahan apa yang akan dipotong. Jika untuk mencukur, pisau yang digunakan adalah silet. Jika untuk memotong roti, maka yang digunakan pisau roti. Begitupun untuk memotong daging, pisau yang digunakan adalah pisau daging. Tidak bisa semua pisau untuk semua bahan yang akan dipotong. Sesuai dengan apa yang akan dipotong. Kurang lebih seperti itulah penerapan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

5. Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan

Menurut para ahli, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi (Nursalam, 2013) antara lain :

a. Menurut Hersey dan Blanchard. Membedakan empat gaya kepemimpinan dimana keempat gaya kepemimpinan tersebut memiliki ciri-ciri tiap gaya kepemimpinan yaitu :

- 1) Intruksi, tinggi tugas dan rendahnya hubungan, komunikasi sejarah, pengambilan keputusan berada pada pemimpin dan peran bawahan sangat minimal, pemimpin banyak memberikan pengarahan atau instruksi

yang spesifik serta mengawasi dengan ketat.

- 2) Konsultasi, tinggi tugas dan rendahnya hubungan, komunikasi dua arah, peran pemimpin dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan cukup besar, bawahan diberi kesempatan untuk memberi masukan dan menampung keluhan.
- 3) Partisipasi, tinggi hubungan tapi rendah tugas, pemimpin dan bawahan bersama-sama memberi gagasan dalam mengambil keputusan.
- 4) Delegasi, rendah hubungan dan rendah tugas, komunikasi dua arah, terjadi diskusi dan pendelegasian antara pemimpin dan bawahan dalam mengambil keputusan pemecahan masalah.

b. Gaya Kepemimpinan Menurut Lippits dan K. White

Terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu :otoriter, demokratis, dan liberal atau laissez fire yang mulai dikembangkan di Universitas Iowa.

1) Otoriter

Gaya kepemimpinan ini memiliki cirri-ciri antara lain:

- a) Wewenang mutlak berada pada pemimpin,
- b) Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin,
- c) Kebijaksanaan selalu dibuat oleh pemimpin,
- d) Komunikasi berlangsung satu arah dari pemimpin kepada bawahan,
- e) Pengawasan terhadap sikap,
- f) Tingkah laku, pembuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara ketat,
- g) Prakarsa harus selalu berasal dari pemimpin,
- h) Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran pertimbangan atau pendapat,
- i) Tugas-tugas bawahan diberikan secara intruktif.
- j) Lebih banyak kritik dari pada pujian,
- k) Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat
- l) Cenderung adanya paksaan, ancaman dan hukuman, kasar dalam bersikap,
- m) Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pemimpin.

2) Demokratis

Gaya kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antar pimpinan dan bawahan.

Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri antara lain :

- a) Wewenang pemimpin tidak mutlak

- b) Pemimpin bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan,
 - c) Keputusan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan,
 - d) Komunikasi berlangsung timbal balik
 - e) Pengawasan dilakukan secara wajar, prakarsa dapat datang dari bawahan,
 - f) Banyak kesempatan dari bawahan untuk menyampaikan saran dan pertimbangan,
 - g) Tugas-tugas yang kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada intruktif,
 - h) Pujian dan kritik seimbang
 - i) Pemimpin mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas masing-masing,
 - j) Pemimpin meminta kesetiaan bawahan secara wajar,
 - k) Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak,
 - l) Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai,
 - m) Tanggung jawab keberhasilan organisasi ditanggung bersama-sama.
- 3) Liberal atau Laissez Fire
- Kepemimpinan gaya liberal atau laissez fire adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia berkerja sama untuk mencapai tujuan dengan lebih banyak menyerahkan pelaksanaan berbagai kegiatan kepada bawahan.
- Ciri gaya kepemimpinan ini antara lain :
- a) Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
 - b) Keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan
 - c) Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan
 - d) Prakarsa selalu berasal dari bawahan
 - e) Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan
 - f) Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok
 - g) Kepentingan pribadi lebih penting dari pada kepentingan kelompok
 - h) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh perorangan.
- 4) Gaya kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan wewenang menurut Gillies (1996) dalam Nursalam (2013) yang dibedakan menjadi empat
- a) Otoriter, merupakan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Gaya kepemimpinannya ini memiliki ciri-ciri yaitu
 - (1) Menggunakan kekuasaan posisi dan kekuatan dalam memimpin,
 - (2) Pemimpin menentukan semua tujuan yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan,

(3) Informasi diberikan hanya pada kepentingan tugas

(4) Motivasi dilakukan dengan imbalan dan hukuman.

b) Demokrasi, merupakan kepemimpinan yang menghargai sifat dan kemampuan setiap staf. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu :

(1) Menggunakan posisi dan pribadinya untuk mendorong ide- ide staf,

(2) Otifasi kelompok untuk enentukan tujuan sendiri,

(3) Membuat rencana dengan pengontrolan dalam menerapannya.

Informasi diberikan seluas-luasnya dengan terbuka.

c) Partisipatif, merupakan gabungan antara otoriter dan demokratis, yaitu pemimpin yang menyampaikan hasil analisis masalah dan kemudian mengusulkan tindakan tersebut pada bawahannya. Pemipin meminta saran dan kritk staf serta mempertimbangkan respon terhadap usulannya.kepuasan akhir yang diambil bergantung pada kelompok.Bebas Tindak, merupakan pimpinan ofisial karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervise dan koordinasi. Staf atau bawahan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Pemimpin hanya sumber informasi dan pengadilan secara minimal.

B. Konsep Manajemen Keperawatan

Perawat adalah profesi yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat merupakan populasi tenaga kesehatan terbesar dalam sebuah instansi pelayanan kesehatan, kisaran 50% lebih jumlah tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit yaitu perawat. Sedangkan sisanya terdiri dari beberapa profesi lain, seperti dokter, bidan, farmasi, gizi, fisioterapis, dll. Populasi yang besar ini sangat menentukan citra rumah sakit, jika baik citra perawat di mata masyarakat, maka rumah sakit tersebut dinilai baik dan memuaskan. Begitupun sebaliknya. Jelek pelayanan perawat yang dirasakan masyarakat, rendah pula kepuasan masyarakat terhadap perawat. Selain itu, perawat merupan profesi yang berada 24 jam di samping pasien. Setiap ada keluhan dan permasalahan, merka akan mengadukan kepada perawat, begitupun mengenai komplain. Disamping itu, perawat merupakan garda terdepan. Pasien yang pertama kali datang ke pelayanan kesehatan, mereka aka menjumpai perawat terlebih dahulu.

Populasi yang besar ini menentukan arah dan kualitas pelayanan dalam sebuah rumah sakit, sehingga perlu pengelolaan yang baik untuk dapat menciptakan pelayanan keperawatan yang profesional dan menaikkan citra pelayanan kesehatan melalui sebuah sistem dalam manajemen keperawatan. Apa itu manajemen keperawatan? Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur.

Manajemen merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan diorganisasi. Manajemen tersebut mencakup kegiatan planning, organizing, actualing, controlling (POAC) terhadap staf, sarana, dan prasarana dalam mencapai tujuan organisasi(Nursalam, 2013).

Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Proses manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai satu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Proses keperawatan sebagaimana manajemen keperawatan terdiri atas pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil(Nursalam, 2013).

Manajemen keperawatan merupakan suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan obyektifitas asuhan keperawatan (Huber,2000). Kelly dan Heidental (2004) menyatakan bahwa manajemen keperawatan dapat di definisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Proses manajemen dibagi menjadi lima tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepersonaliaan, pengarahan dan pengendalian (Marquis dan Huston, 2010). Swanburg (2000) menyatakan bahwa manajemen keperawatan adalah kelompok dari keperawatan menejer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi proses dimana perawat manajer menjalankan profesi mereka.

Manajemen keperawatan adalah proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manager keperawatan adalah merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengawasi keuangan yang ada, peralatan dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomi pada pasien (Gillies, 2000).

C. Fungsi Manajemen Keperawatan

Ketika mahasiswa ditanya apa fungsi dari manajemen? Kebanyakan mahasiswa akan mengatakan: "mengatur sesuatu agar lebih terarah" atau jawaban yang sejenisnya. Sayangnya jawabannya salah. Lalu apa fungsi manajemen? Cukup ingat 5 kata ini yaitu POSAC. Apa itu POSAC? POSAC merupakan singkatan dari P = Planning (Perencanaan), O= Organizing (Pengorganisasian), S=Staffing (kepegawaian), A= Actuating (Pengarahan), C= Controlling (Pengendalian). Berikut uraian singkat mengenai POSAC:

1. Perencanaan (Planning)

(Swanburg R., 2000 dalam Kholid, 2013), planning memutuskan seberapa luas akan dilakukan, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Fungsi perencanaan merupakan suatu penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai, perencanaan sangat penting untuk melakukan tindakan.

Didalam proses keperawatan perencanaan membantu perawat dalam menentukan tindakan yang tepat bagi klien dan menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan konsep dasar keperawatan.

a. Tujuan perencanaan

- 1) Untuk menimbulkan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan.
- 2) Agar penggunaan personel dan fasilitas tersedia efektif.
- 3) Efektif dalam hal biaya.
- 4) Membantu menurunkan elemen perubahan, karena perencanaan berdasarkan masa lalu dan akan datang.
- 5) Dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan untuk berubah.

b. Tahapan dalam perencanaan

- 1) Menetapkan tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan sekarang.
- 3) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan serangkaian kegiatan.
- 5) Jenis perencanaan :

a) Perencanaan strategi

Perencanaan yang sifat jangka panjang yang ditetapkan oleh pemimpin dan merupakan arahan umum suatu organisasi. Digunakan untuk mendapatkan dan mengembangkan pelayanan keperawatan yang diberikan kepadapasien, juga digunakan untuk merevisi pelayanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa kini.

b) Perencanaan operasional

Menguraikan aktivitas dan prosedur yang akan digunakan serta menyusun jadwal waktu pencapaian tujuan, menentukan siapa perawat yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dan prosedur serta menggambarkan cara menyiapkan perawat dalam bekerja dan prosedur untuk mengevaluasi perawatan pasien.

c) Manfaat perencanaan

- (1) Membantu proses manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan.
- (2) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi

lebih jelas.

- (3) Membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat.
- (4) Memberikan cara pemberian perintah yang tepat untuk pelaksanaan.
- (5) Memudahkan koordinasi.
- (6) Membuat tujuan lebih khusus, lebih terperinci dan lebih mudah dipahami.
- (7) Meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.
- (8) Menghemat waktu dan dana.

d) Keuntungan perencanaan

- (1) Meningkatkan peluang sukses.
- (2) Membutuhkan pemikiran analitis.
- (3) Mengarahkan orang ketindakan.
- (4) Memodifikasi gaya manajemen.
- (5) Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.
- (6) Meningkatkan keterlibatan anggota

e) Kelemahan perencanaan

- (1) Kemungkinan pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan berlebihan pada kontribusi nyata.
- (2) Cenderung menunda kegiatan.
- (3) Terkadang kemungkinan membatasi inovasi dan inisiatif
- (4) Kadang-kadang hasil yang lebih baik didapatkan oleh penyelesaian situasional individual dan penanganan suatu masalah pada saat masalah itu terjadi.
- (5) Terdapat rencana yang diikuti oleh/atau dengan rencana yang tidak konsisten.

c. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian suatu langkah untuk menetapkan, mengelompokkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang-wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1) Manfaat pengorganisasian, akan dapat diketahui:

- a) Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok.
- b) Hubungan organisatoris antara orang-orang didalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya.
- c) Pendelegasian wewenang.

- d) Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik.
- 2) Tahapan dalam pengorganisasian
 - a) Tujuan organisasi harus dipahami staf, tugas ini sudah tertuang dalam fungsi manajemen.
 - b) Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok untuk mencapai tujuan.
 - c) Menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan- satuan kegiatan yang praktis.
 - d) Menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.
 - e) Penugasan personil yang tepat dalam melaksanakan tugas.
 - f) Mendelegasikan wewenang.
- d. Kepegawaian (Staffing)

Staffing merupakan metodologi pengaturan staff, merupakan proses yang teratur, sistematis, berdasarkan rasional diterapkan untuk menentukan jumlah dan jenis personal suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Komponen yang termasuk dalam fungsi staffing prinsip: rekrutmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan klasifikasi pasien. Komponen tersebut merupakan suatu proses yang mana nantinya berhubungan dengan penjadwalan siklus waktu kerja bagi semua personel yang ada. Terdapat beberapa langkah yang diambil untuk menentukan waktu kerja dan istirahat pegawai, yaitu:

 - 1) Menganalisa jadwal kerja dan rutinitas unit.
 - 2) Memberikan waktu masuk dan libur pekerjaan.
 - 3) Memeriksa jadwal yang telah selesai
 - 4) Menjamin persetujuan jadwal yang dianjurkan dari manajemen keperawatan.
 - 5) Memasang jadwal untuk memberitahu anggota staff.
 - 6) Memperbaiki dan memperbaharui jadwal tiap hari.
- e. Pengarahan (Directing)
 - 1) Pengertian Pengarahan

Marquis (2013), menyatakan pengarahan merupakan proses penerapan rencana manajemen untuk menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan melalui berbagai arahan.

Sri (2012), menyatakan pengarahan suatu cara untuk mengerjakan dan memberikan bimbingan agar dapat bekerja secara optimal dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan sumber daya yang tersedia berdasarkan kemampuan dan keahliannya.

Asmuji (2014), menyatakan pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga, menyangkut berbagai tingkah laku manusia yang berbeda-beda.

2) Tujuan Pengarahan

Asmuji (2014), menyatakan terdapat lima tujuan dan fungsi pengarahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengarahan bertujuan menciptakan kerja sama yang lebih efisien. Pengarahan memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dan bawahan. Manajer keperawatan setingkat kepala ruangan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan bawahannya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh, kegiatan supervisi tindakan keperawatan akan dapat mengurangi atau meminimalisasi kesalahan tindakan sehingga akan dapat meminimalisasi bahan, alat atau waktu tindakan bila dibandingkan jika terjadi kesalahan karena tidak ada supervisi.
- b) Pengarahan bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Banyak hal yang terkait dengan kegiatan pengarahan di dalam ruang perawatan. Seperti halnya supervisi, pendelegasian di dalam ruang perawatan akan dapat memberikan peluang bagi yang diberikan delegasi untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara otonomi.
- c) Pengarahan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Perawat yang diarahkan jika salah, diberi motivasi jika kinerja menurun dan diberi apresiasi atas hasil kerja akan memberikan penguatan rasa memiliki dan menyukai pekerjaannya.
- d) Pengarahan bertujuan mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Selain itu, kepemimpinan yang adil merupakan kunci sukses dalam memberikan motivasi kerja dan meningkatkan prestasi kerja perawat bawahan.

3) Unsur-unsur Pengarahan

Pengarahan atau juga disebut "penggerakan" merupakan upaya memengaruhi bawahan agar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna mengarahkan atau menggerakkan bawahan,

ada beberapa unsur yang perlu di dipahami dan diperhatikan bagi seorang manajer keperawatan.

- a) Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.
- b) Motivasi hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.
- c) Komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan. Dalam organisasi pelayanan keperawatan, dalam ada beberapa bentuk kegiatan pengarahan yang didalamnya terdapat aplikasi komunikasi, antara lain sebagai berikut.

(1)Operan

Merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan mengoperkan asuhan keperawatan kepada shift berikutnya.

(2)Pre – Conference

Komunikasi ketua tim/penanggung jawab shift dengan perawat pelaksana setelah selesai operan.

(3)Post-Conference

Komunikasi ketua tim/perawat dengan perawat pelaksana sebelum timbang terima mengakhiri dinas dilakukan

(4)Pendelegasian

Kegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

(5)Supervisi

Bentuk komunikasi yang bertujuan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

d) Manajemen Konflik dalam Ruang Perawatan

Ruang perawatan merupakan suatu sistem tempat manusia berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam ruang perawatan mempunyai kemungkinan terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok.

Abidin (2015), menyatakan kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi pengarahan , yaitu delegasi, supervisi, motivasi, manajemen konflik serta komunikasi dan kolaborasi.

(1)Delegasi

Pendelegasian kegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain yang bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang

telah ditetapkan. Bentuk delegasi diruang perawatan antara lain kepala ruang mendelegasikan tugas kepada ketua tim/perawat primer atau penanggung jawab shift. Sedangkan, ketua tim/perawat primer mendelegasikan tugas kepada perawat pelaksana agar kegiatan pendelegasian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, harus dilakukan komunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan antara person yang memberikan delegasi dan person yang diberikan delegasi.

Kesumanjaya (2010), menyatakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif yaitu tetapkan tujuan, tegaskan tanggung jawab dan wewenang, berikan motivasi kepada bawahan, manajer dapat memberikan dorongan bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif, meminta penyelesaian kerja, berikan latihan, adakan pengawasan yang memadai.

(2)Supervisi

Asmuji (2014), menyatakan supervisi merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Supervisi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Supervisi keperawatan, fokus utamanya bukan pada kegiatan pemeriksaan yang mencari-cari kesalahan, melainkan pada kegiatan supervisi ini lebih mengarah pada pengawasan partisipatif. Kegiatan supervisi keperawatan memungkinkan terjadinya pemberian penghargaan, diskusi dan juga bimbingan yang bertujuan untuk mencarjalan keluar jika terjadi kesulitan dalam tindakan keperawatan.

(3)Motivasi

Motivasi berasal dari kata Latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ekstrinsik yang merangsang perilaku tertentu dan respons intrinsik yang menampakkan perilaku manusia.

Motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran. Motivasi suatu kondisi yang

menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan (persistence) pada tingkah laku tersebut.

Disimpulkan motivasi suatu dorongan proses psikologis yang menimbulkan perilaku tertentu dan ikut menentukan intensitas, arah, ketekunan dan ketahanan pada perilaku tersebut sesuai tujuan yang ditetapkan.

(4) Manajemen konflik

Konflik merupakan proses yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif. Konflik merupakan masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dua orang atau lebih. Konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.

Disimpulkan konflik merupakan proses yang bermula ketika interaksi pihak satu dengan yang lain memunculkan masalah internal maupun eksternal sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai - nilai atau keyakinan-keyakinan.

(5) Komunikasi dan kolaborasi

Marwansyah (2010), menyatakan komunikasi merupakan pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan pemahaman yang sama.

Asmuji (2014), menyatakan komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan.

Amin (2008), menyatakan komunikasi merupakan hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya.

Suprpto (2011), menyatakan komunikasi suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia. Disimpulkan komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan persamaan makna dan mencapai satu tujuan yang sama.

(Gitosudarmo & Mulyono 1997 dalam Hatta, 2008), menyatakan kepala ruangan sebagai koordinator kegiatan perlu menciptakan kerjasama yang selaras satu sama lain dan saling menunjang untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

f. Pengendalian/evaluasi (Controlling)

Kholid (2013), menyatakan controlling merupakan proses pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi. Tugas seorang manajerial dalam usaha menjalankan dan mengembangkan fungsi pengawasan manajerial perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- 1) Pengawasan yang dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur.
- 2) Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang amat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- 3) Standart untuk kerja yang akan diawasi perlu dijelaskan kepada semua staf, sehingga staf dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kegiatan program.
- 4) Kontrol sebagai pengukuran dan koreksi kinerja untuk meyakinkan bahwa sasaran dan kelengkapan rencana untuk mencapai tujuan telah tersedia, serta alat untuk memperbaiki kinerja.

Terdapat 10 karakteristik suatu sistem kontrol yang baik:

- 1) Harus menunjukkan sifat dari aktifitas
- 2) Harus melaporkan kesalahan-kesalahan dengan segera
- 3) Harus memandang kedepan
- 4) Harus menunjukkan penerimaan pada titik krisis
- 5) Harus obyektif
- 6) Harus fleksibel
- 7) Harus menunjukkan pola organisasi
- 8) Harus ekonomis
- 9) Harus mudah dimengerti
- 10) Harus menunjukkan tindakan perbaikan

Ada 2 metode pengukuran yang digunakan untuk mengkaji pencapaian tujuan keperawatan, yaitu:

1) Analisa data

Perawat melihat gerakan, tindakan dan prosedur yang tersusun dalam pedoman tertulis, jadwal, aturan, catatan, anggaran. Hanya ukuran fisik saja dan secara relatif beberapa alat digunakan untuk analisa tugas dalam keperawatan.

2) Kontrol kualitas

Perawat dihadapkan pada pengukuran kualitas dan akibat-akibat dari pelayanan keperawatan.

Manfaat pengawasan:

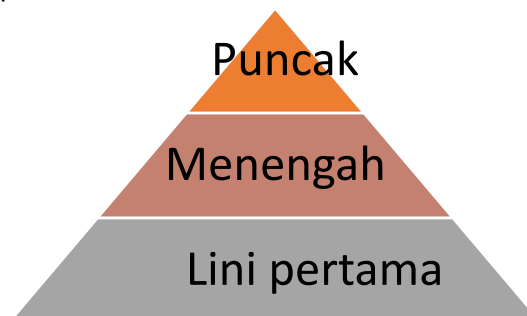
Apabila fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan tepat maka akan diperoleh manfaat:

- a) Dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau rencana kerja.
- b) Dapat diketahui adanya penyimpangan pada pengetahuan dan pengertian staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c) Dapat diketahui apakah waktu dan sumber daya lainnya telah mencukupi kebutuhan dan telah digunakan secara benar.

Dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau bentuk promosi dan latihan kerja

D. Tingkatan Manajer Keperawatan

Tingkatan manajer keperawatan dibagi menjadi tiga, yaitu manajemen puncak, menengah, dan lini pertama.



1. Manajemen puncak

Tingkatan yang pertama dan menduduki level paling atas adalah manajemen puncak atau top manajemen. Contoh Manajemen puncak dalam manajemen keperawatan adalah Kepala bidang keperawatan.

Adapun tugas dan fungsi dari manajemen puncak adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu. Baik itu jangka waktu singkat ataupun tujuan jangka panjang.
- b. Menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, sampai dengan investor terkait.
- c. Membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi dan misi yang ada.
- d. Mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisir.

- e. Punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan.
- f. Mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja, maupun arus keuangan. Semua elemen tersebut yang mendukung dan mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengendalikannya dengan baik agar perusahaan berjalan lancar.

2. Manajemen menengah

Tingkatan yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah. Level ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama. Middle management bertanggung jawab kepada top management karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Di tingkat ini, manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang di bawahnya. Contoh Manajemen menengah yaitu Kepala unit pelayanan atau supervisor, Manajer keperawatan, Kepala keperawatan, Ada beberapa tanggung jawab yang diperlukan dalam menjabat di posisi ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang disertai tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama.
- b. Menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik.
- c. Selain itu, penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja agar tetap produktif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi yang optimal.
- d. Merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen.
- e. Melakukan seleksi, pemilihan rekrutmen, sampai dengan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya secara tepat.
- f. Mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan.
- g. Membangun kerja sama dan suasana yang kondusif di setiap departemen guna menjaga kebersinambungan yang baik.

3. Manajemen lini pertama

Manajemen lini pertama memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Adapun yang termasuk ke manajer lini pertama adalah Kepala ruang perawatan, Ketua tim perawatan, Perawat pemberi asuhan primer, Tim pemimpin, Manajer kasus. Dengan tanggung jawab ini membuat para manajer harus mampu memiliki keahlian tertentu, seperti komunikasi dan teknis. Selain itu, ada juga beberapa tugas lain yang dimiliki oleh manajer lini pertama, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional.
- b. Melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah.
- c. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman.
- d. Melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja.
- e. Membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja.
- f. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa pelayanan yang baik di instansi
- g. Bertanggung jawab dalam menjaga attitude yang baik dari tenaga kerja di instansi.

E. Peran Manajer

Untuk melakukan pekerjaan mereka, manajer mengemban peran-peran yang berbeda ini. Tidak ada manajer yang selalu berada dalam satu peran, tetapi berpindah-pindah. Peran-peran ini adalah kepemimpinan (atau interpersonal), informasional, dan pengambilan keputusan. Peran-peran ini ditulis secara rinci pada tahun 1970-an oleh Henry Mintzberg.

1. Kepemimpinan dan Peran Interpersonal

Kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengomunikasikan visi dan menginspirasi orang untuk menerima visi tersebut. Selain itu, Manajer puncak sering kali dituntut untuk memenuhi apa yang digambarkan Mintzberg sebagai aktivitas figuratif. Mereka adalah wajah publik dari tim manajemen dan mewakili bisnis dalam forum hukum, ekonomi, dan sosial. Manajer menengah juga merupakan pemimpin, meskipun fokus mereka mungkin lebih pada keterampilan interpersonal, seperti memotivasi karyawan, menegosiasikan gaji, dan mendorong inovasi dan kreativitas. Manajer lini pertama memimpin baik melalui contoh ketika mereka secara aktif berpartisipasi dalam tugas yang diberikan kepada pekerja mereka maupun dengan memodelkan kebijakan dan etika kerja organisasi.

2. Peran Informasional

Peran informasional melibatkan penerimaan dan pengiriman informasi—baik sebagai juru bicara, mentor, pelatih, atau administrator. Seorang manajer puncak adalah juru bicara organisasi dan harus menyadari bahwa pendapat pribadi pun akan berdampak (baik atau buruk) pada organisasi. Dengan arus informasi yang bebas di Internet, sangat sulit bagi para manajer puncak untuk memisahkan identitas pribadi mereka dari posisi organisasi mereka.

Manajer tingkat menengah harus dengan cermat menentukan informasi apa dari manajemen puncak yang harus dibagikan kepada orang lain, bagaimana informasi itu harus ditafsirkan, dan bagaimana informasi itu harus disajikan. Demikian pula, mereka harus mempertimbangkan nilai informasi yang mereka terima dari manajer lini pertama dan karyawan untuk memutuskan apa yang harus diteruskan ke manajemen puncak. Jika informasi yang disampaikan cenderung tidak benar atau remeh, maka manajer akan dipandang sebagai sumber yang tidak dapat diandalkan dan pendapatnya tidak diperhitungkan.

Peran informasional bagi manajer lini pertama terutama adalah menyebarluaskan apa yang telah diberikan kepada mereka dan membantu karyawan untuk melihat bagaimana kontribusi mereka sendiri memajukan tujuan organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan memahami apa yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Semua manajer dituntut untuk membuat keputusan, tetapi manajer di berbagai tingkatan membuat berbagai jenis keputusan yang berbeda. Menurut Mintzberg, ada empat jenis utama peran pengambilan keputusan manajemen. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

- a. Pengusaha. Pengusaha dalam suatu perusahaan biasanya adalah manajer tingkat atas. Mereka mengidentifikasi peluang ekonomi, memimpin inisiatif perubahan, dan membuat keputusan produk.
- b. Penanganan gangguan. Manajer puncak dan menengah akan bereaksi terhadap gangguan (peristiwa tak terduga) dalam organisasi—baik internal maupun eksternal. Mereka akan memutuskan tindakan korektif apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
- c. Pengalokasi sumber daya. Semua tingkatan manajemen akan membuat keputusan alokasi sumber daya, tergantung pada apakah keputusan tersebut memengaruhi seluruh organisasi, satu departemen, atau tugas atau aktivitas tertentu.
- d. Negosiator. Bergantung pada dampaknya terhadap organisasi, sebagian besar negosiasi dilakukan oleh manajer tingkat atas dan menengah. Manajer tingkat atas akan menangani negosiasi yang memengaruhi seluruh organisasi, seperti kontrak serikat pekerja atau perjanjian perdagangan. Manajer tingkat menengah menegosiasikan sebagian besar keputusan gaji dan perekrutan.

Singkatnya, manajer harus memainkan banyak peran. Beberapa orang lebih baik daripada yang lain dalam peran tertentu dan cenderung akan diminta untuk pekerjaan tersebut. Menempatkan tim manajemen yang beragam akan

memastikan bahwa organisasi memiliki cukup manajer untuk menghadapi sebagian besar tantangan.

F. Latihan Soal

1. Sebutkan definisi pemimpin dan kepemimpinan!
2. Sebutkan apa saja gaya kepemimpinan!
3. Sebutkan apa saja fungsi-fungsi manajemen!
4. Sebutkan tingkatan manajer keperawatan!
5. Sebutkan peran manajer!

G. Rangkuman Materi

Manajemen Keperawatan merupakan pengelolaan sumber daya keperawatan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen keperawatan sangat penting dalam pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlangsungan pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas dan profesional. Manajer keperawatan terdiri dari 3 tingkatan yaitu top manajer, manajer menengah dan manajer lini pertama. Masing-masing tingkatan manajer memiliki kemampuan dan tugas yang berbeda. Adapun fungsi-fungsi manajemen ada 5 yaitu POSAC. P adalah *planning*, O adalah *Organizing*, S adalah *Staffing*, A adalah *Actuating*, C adalah *Controlling*. Dalam menjalankan fungsi manajemen keperawatan para manajer menerapkan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola atau style yang digunakan manajer untuk menggerakkan anggotanya. Manajer dapat menggunakan berbagai gaya kepemimpinan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam artian tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Gaya kepemimpinan seperti mata pisau yang digunakan sesuai dengan bahan apa yang akan diiris atau dipotong.

H. Daftar Pustaka

- Asmuji. (2014). Manajemen Keperawatan : Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar. Ruzz Media
- Douglas, Laura Mae. (1992) The effective Nurse : Leader and Manager ., 4 Th. Ed., Mosby - year book, Inc.
- Febriantina, Susan; Kimura, Calvin; Nurkhairani, Hana; Wicaksono, M. Fajar Bayu; Nugraha, Pradipta Afrah dan Primadhita, Safrina. 2025. Literature Review : Teori-Teori Kepemimpinan (Modern dan Tradisional). *Jurnal of Student Research*, 3 (1), 97 – 109. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3531>
- Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

- Harsono. (2010). Paradigma "Kepemimpinan Ketua" dan Kelemahannya. Makara, Sosial Humaniora. 14(1), 56-64
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huber, D. L. (2010). Leadership and Nursing Care Management ed. 4. Maryland Heights: Saunders/Elsevier.
- John dan Lynn Bruton. Peran Manajemen. Published by Lumen Learning. License: CC BY: Attribution Diperoleh dari https://courses-lumenlearning-com.translate.goog/wm-principlesofmanagement/chapter/management-roles/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=All%20managers%20must%20be%20comfortable,%2C%20informational%2C%20and%20decision%20making. Diakses tanggal 10 Februari 2025
- Kelly & Heidental, (2004). Essential of Nursing leadership and Management. New York: Thomson Delmar Learning
- Kholid.(2013). Manajemen Kepemimpinan dalam Keperawatan. Jakarta: CV. TRANS INFO MEDIA
- Marquis, B. L. & Huston, C. J. (2010). *Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan: Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Jakarta:EGC.
- Maryana. 2023. Manajemen Keperawatan. Pekalongan: NEM
- Nursalam. (2013). Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam praktik keperawatan professional, edisi 3, Jakarta: Salemba Medika
- Sri, A. W. (2012). Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Keperawatan. Yogyakarta: Fitramaya
- Yaslis, I. (2004). Perencanaan SDM rumah sakit. teori, metoda dan formula. Depok: FKMUI

BAB 2

MANAJEMEN DAN PENGATURAN ALUR KERJA DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PASIEN COVID-19

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan luar biasa bagi sistem kesehatan global. Keberhasilan dalam penanganan pasien sangat bergantung pada manajemen dan pengaturan alur kerja yang efektif. Pengelolaan alur kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik menjadi kunci untuk memastikan keselamatan pasien, tenaga kesehatan, serta efisiensi sumber daya dalam pelayanan keperawatan.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam mengatur alur kerja pelayanan kesehatan terutama dalam situasi pandemi COVID-19 secara efektif dan efisien.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mahasiswa mampu menjelaskan, mengelola, dan mengevaluasi strategi pengaturan alur kerja pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19 berdasarkan prinsip manajemen klinis dan kepemimpinan efektif.

Sub CPMK

- Menjelaskan prinsip dasar manajemen alur kerja dalam penanganan pasien COVID-19.
- Mengelola proses kerja tim keperawatan dalam penanganan pasien COVID-19.
- Mengevaluasi efektivitas pengaturan alur kerja dalam situasi pandemi COVID-19.

Uraian Materi

A. Prinsip Dasar Manajemen Alur Kerja dalam Penanganan Pasien COVID-19

Pengaturan alur kerja pasien COVID-19 membutuhkan penerapan prinsip dasar berikut:

1. Triase yang Tepat

Triase merupakan langkah awal yang esensial dalam pengelolaan pasien COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara cepat tingkat keparahan kondisi pasien sehingga prioritas pelayanan dapat diberikan dengan tepat. Proses triase mencakup pengukuran suhu tubuh, saturasi oksigen, penilaian gejala pernapasan (seperti batuk, sesak napas, atau kesulitan bernapas), serta evaluasi riwayat kesehatan mendasar pasien, seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit kronis lainnya. Metode triase dapat menggunakan sistem klasifikasi warna atau skor klinis standar untuk memudahkan pengelompokan pasien secara cepat dan akurat. Efektivitas triase mengurangi risiko kepadatan di fasilitas kesehatan dan transmisi silang antar pasien serta petugas kesehatan.

2. Zonasi Perawatan

Zonasi perawatan adalah teknik pemisahan pasien berdasarkan status infeksi mereka. Penetapan zona melibatkan:

- a. **Zona Merah:** Dikhususkan bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di zona ini, penerapan protokol isolasi ketat dan APD level tinggi wajib dilakukan.
- b. **Zona Kuning:** Untuk pasien yang menunjukkan gejala infeksi tetapi belum terkonfirmasi positif (suspect atau dalam observasi). Zona ini membutuhkan perhatian khusus untuk memonitor perkembangan klinis dan menghindari penularan ke pasien lain.
- c. **Zona Hijau:** Diperuntukkan bagi pasien tanpa gejala atau terbukti negatif setelah menjalani pemeriksaan laboratorium. Zona ini harus steril dari potensi risiko infeksi COVID-19.

Implementasi zonasi membutuhkan infrastruktur yang jelas, protokol yang ketat, dan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

3. Alokasi Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi

Alokasi tenaga kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan keahlian dan pengalaman tenaga kesehatan. Perawat dan dokter dengan pengalaman dalam penanganan infeksi dan kondisi kritis ditempatkan di zona dengan risiko tinggi seperti zona merah. Tenaga kesehatan dengan keahlian dasar atau administrasi bekerja di area dengan risiko lebih rendah untuk membantu

pengelolaan pasien secara umum. Strategi rotasi kerja juga penting untuk mencegah burnout dan memastikan tenaga kesehatan tetap dalam kondisi optimal selama pandemi.

4. Pengelolaan Logistik dan Peralatan Medis

Manajemen logistik meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pemantauan stok alat medis, obat-obatan, APD, ventilator, serta oksigen. Sistem inventaris yang optimal memastikan bahwa setiap peralatan dan logistik tersedia dalam jumlah yang memadai, mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan yang berlebihan. Selain itu, manajemen logistik juga mencakup jadwal rutin pemeliharaan peralatan medis guna memastikan operasionalisasi yang aman dan efisien.

B. Pengelolaan Proses Kerja Tim Keperawatan

Pengelolaan tim keperawatan dalam penanganan pasien COVID-19 merupakan elemen krusial yang membutuhkan strategi manajemen dan kepemimpinan yang komprehensif. Berikut rincian faktor kunci yang harus diperhatikan secara mendalam:

1. Komunikasi yang Jelas dan Efektif

Komunikasi efektif adalah fondasi utama dalam pengelolaan tim keperawatan. Dalam situasi pandemi COVID-19, informasi yang jelas mengenai protokol keselamatan, kondisi pasien, dan prosedur terbaru sangat penting. Strategi komunikasi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Briefing rutin harian untuk memastikan setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab harian.
- b. Debriefing untuk merefleksikan kinerja harian, membahas tantangan yang muncul, serta menentukan langkah perbaikan selanjutnya.
- c. Penggunaan alat komunikasi digital (seperti aplikasi pesan instan dan perangkat lunak kolaborasi) untuk menyampaikan informasi secara real-time.

2. Koordinasi Tugas yang Optimal

Koordinasi tugas yang efektif memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara sinergis tanpa terjadi duplikasi atau kelalaian tugas. Manajer keperawatan perlu mengalokasikan tugas berdasarkan keahlian individu dan mempertimbangkan kapasitas kerja masing-masing anggota tim. Strategi pendukung koordinasi optimal antara lain:

- a. Penyusunan jadwal tugas yang detail dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan beban kerja tim.
- b. Penggunaan checklist untuk memastikan semua tugas penting telah diselesaikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

- c. Implementasi teknologi seperti aplikasi manajemen tugas dan kalender digital untuk pemantauan tugas secara transparan.

3. Pengambilan Keputusan Kolaboratif

Proses pengambilan keputusan yang kolaboratif mendorong partisipasi aktif seluruh anggota tim keperawatan. Diskusi multidisiplin dan pertukaran ide secara terbuka akan menghasilkan keputusan klinis yang lebih akurat dan efektif. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kolaboratif mencakup:

- a. Diskusi tim rutin untuk membahas kasus-kasus yang kompleks atau situasi kritis yang membutuhkan perhatian khusus.
- b. Menyediakan ruang bagi tim untuk saling bertukar informasi, pendapat, serta pengalaman klinis yang berharga.
- c. Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas, sehingga setiap anggota tim memahami proses dan tanggung jawabnya dalam keputusan bersama.

4. Briefing dan Debriefing Harian

Briefing harian memastikan tim siap menghadapi tugas-tugas dengan rencana kerja yang jelas. Debriefing harian menjadi alat evaluasi untuk mengukur efektivitas kerja harian, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi perbaikan yang cepat dan tepat. Aktivitas ini juga dapat membangun solidaritas tim dan semangat kerja sama.

5. Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan

Teknologi informasi menjadi penunjang utama dalam efektivitas manajemen keperawatan. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data pasien yang efisien dan akurat. Sistem ini mencakup:

- a. Rekam medis elektronik yang memungkinkan akses cepat terhadap data pasien secara real-time.
- b. Sistem laporan kondisi pasien digital yang mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi.
- c. Manajemen inventaris digital untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan secara kontinu dan tepat waktu.

6. Pelatihan Rutin Penggunaan APD

Pelatihan rutin dalam penggunaan APD adalah langkah penting untuk menjaga keamanan tenaga kesehatan. Simulasi dan latihan rutin membantu tim keperawatan merasa lebih siap dan percaya diri, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam prosedur pemakaian dan pelepasan APD. Hal ini juga penting untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan tenaga kesehatan.

Implementasi strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan akan mendukung efektivitas proses kerja tim keperawatan, menjaga keselamatan

pasien dan tenaga kesehatan, serta menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang optimal selama pandemi COVID-19.

C. Evaluasi Efektivitas Pengaturan Alur Kerja

Evaluasi efektivitas pengaturan alur kerja merupakan proses krusial dalam pelayanan pasien COVID-19 untuk memastikan standar pelayanan tinggi dan perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi mencakup indikator dan metode evaluasi yang rinci:

1. Indikator Evaluasi

Evaluasi efektivitas pengaturan alur kerja mengacu pada beberapa indikator utama berikut:

- a. **Waktu Tunggu Pasien:** Waktu tunggu pasien digunakan untuk mengukur efisiensi proses pelayanan dari saat pasien tiba hingga mendapatkan layanan medis pertama. Pengukuran ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk mengurangi penundaan pelayanan yang berisiko memperburuk kondisi pasien.
- b. **Tingkat Kepuasan Pasien:** Kepuasan pasien mencerminkan persepsi pasien terhadap kualitas layanan yang diterima. Ini diukur melalui survei dan wawancara langsung dengan pasien mengenai kualitas komunikasi, kenyamanan fasilitas, kecepatan pelayanan, serta sikap dan profesionalisme tenaga kesehatan.
- c. **Tingkat Kepuasan Tenaga Kesehatan:** Indikator ini sangat penting karena mencerminkan efisiensi organisasi kerja dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Evaluasi dilakukan melalui survei internal untuk mengukur kepuasan terkait beban kerja, jam kerja, dukungan manajemen, fasilitas pendukung, serta lingkungan kerja secara umum.
- d. **Kejadian Infeksi Nosokomial:** Pengukuran kejadian infeksi nosokomial, terutama infeksi COVID-19 di fasilitas kesehatan, merupakan indikator langsung dari efektivitas protokol pencegahan dan pengendalian infeksi. Angka ini sangat penting untuk menilai keberhasilan penerapan protokol kesehatan.

2. Metode Evaluasi

Evaluasi efektivitas alur kerja menggunakan beberapa metode berikut:

- a. **Audit Klinis Rutin:** Audit klinis dilakukan secara berkala untuk meninjau kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kualitas dokumentasi klinis, dan efektivitas prosedur pelayanan. Tim audit multidisiplin melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, kemudian menghasilkan laporan yang berisi rekomendasi untuk perbaikan.

- b. **Survei Kepuasan Pasien dan Tenaga Kesehatan:** Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara periodik atau melalui wawancara langsung yang terstruktur. Informasi yang dikumpulkan mencakup pengalaman langsung pasien dan tenaga kesehatan terkait efisiensi layanan, kualitas komunikasi, kelengkapan fasilitas, dan responsivitas sistem terhadap kebutuhan mereka.
- c. **Pertemuan dan Umpan Balik Staf Berkala:** Pertemuan rutin diadakan untuk membuka dialog terbuka dengan staf. Dalam pertemuan ini, staf didorong untuk berbagi pengalaman, kendala yang dihadapi, serta memberikan saran konkret mengenai upaya perbaikan alur kerja.
- d. **Analisis Data Komprehensif:** Pengumpulan dan analisis data secara berkala melalui sistem informasi manajemen kesehatan membantu mengidentifikasi pola dan tren yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Data yang dikumpulkan dapat berupa waktu tunggu pasien, angka kepuasan, kejadian infeksi, dan faktor lain yang relevan.

3. Implementasi Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi harus diikuti dengan implementasi tindakan korektif yang berkelanjutan dalam siklus sebagai berikut:

- a. **Identifikasi Hambatan:** Analisis hasil evaluasi untuk mengenali faktor-faktor penghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- b. **Perencanaan Tindakan Korektif:** Merancang solusi yang spesifik, realistis, dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut, melibatkan seluruh tim untuk menjamin relevansi dan penerimaan solusi.
- c. **Implementasi Solusi:** Pelaksanaan tindakan korektif secara konsisten, memastikan bahwa semua staf memahami dan menerapkan perubahan yang ditetapkan.
- d. **Evaluasi Ulang:** Peninjauan kembali efektivitas solusi yang diterapkan melalui evaluasi lanjutan untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan untuk modifikasi lebih lanjut.

Proses evaluasi ini merupakan mekanisme penting dalam menciptakan pelayanan keperawatan yang efektif, aman, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan, khususnya selama pandemi COVID-19.

D. Strategi Praktis dan Implementasi

Dalam penanganan pandemi COVID-19, penerapan strategi praktis yang jelas dan implementasi yang konsisten merupakan faktor utama untuk memastikan kualitas pelayanan optimal dan keselamatan pasien serta tenaga kesehatan. Berikut uraian mendetail mengenai strategi-strategi praktis tersebut:

1. Zonasi Terpisah antara Pasien Suspect dan Terkonfirmasi COVID-19

Zonasi yang terorganisasi dengan baik bertujuan untuk mengendalikan transmisi infeksi. Implementasi ini mencakup:

- a. **Zona Merah:** Area isolasi khusus bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan fasilitas medis yang lengkap dan ketat dalam penggunaan APD.
- b. **Zona Kuning:** Area pengamatan dan isolasi sementara bagi pasien dengan gejala tetapi belum terkonfirmasi positif. Di zona ini, pasien diawasi secara ketat dan diperiksa secara reguler.
- c. **Zona Hijau:** Area bebas infeksi untuk pasien yang tidak menunjukkan gejala atau pasien dengan hasil tes negatif. Area ini harus dijaga steril dengan protokol ketat.
- d. **Prosedur khusus:** Menyediakan jalur khusus bagi pasien dan tenaga kesehatan untuk setiap zona, dengan stasiun desinfeksi di setiap pintu masuk dan keluar zona, serta pelatihan staf mengenai prosedur sterilisasi rutin.

2. Penjadwalan Tim Perawat dengan Rotasi Efektif

Penjadwalan yang baik bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan, serta menjaga kualitas layanan. Langkah implementasi meliputi:

- a. **Penyusunan jadwal shift:** Memperhatikan kapasitas fisik dan mental staf, dengan pembagian waktu kerja dan istirahat yang seimbang.
- b. **Rotasi tim secara reguler:** Memastikan ada rotasi yang memungkinkan tenaga kesehatan memiliki waktu pemulihan yang cukup antar shift.
- c. **Area istirahat yang memadai:** Menyediakan fasilitas istirahat yang nyaman, dengan akses makanan dan minuman bergizi, serta ruang privat untuk istirahat optimal.

3. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Edukasi

Pelatihan yang berkualitas tinggi adalah aspek penting dalam kesiapan tenaga kesehatan. Langkah pelaksanaannya meliputi:

- a. **Pelatihan rutin penggunaan APD:** Melakukan pelatihan berkala mengenai cara pemakaian, pelepasan, dan pembuangan APD dengan benar, untuk mengurangi risiko infeksi.
- b. **Simulasi situasi darurat:** Mengadakan pelatihan simulasi secara berkala yang mencakup situasi-situasi kritis dan keadaan darurat, untuk meningkatkan respons cepat dan kesiapan tenaga kesehatan.
- c. **Edukasi rutin tentang protokol kesehatan terbaru:** Mengupdate staf secara reguler tentang protokol kesehatan terbaru, manajemen stres, teknik komunikasi efektif antar tim, dan strategi pengendalian infeksi.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi mempercepat proses dokumentasi medis, meningkatkan akurasi data, dan memperbaiki komunikasi antar tim kesehatan. Implementasi ini mencakup:

- a. **Sistem rekam medis elektronik (EMR):** Digunakan untuk memudahkan akses informasi pasien secara cepat, aman, dan akurat.
- b. **Aplikasi komunikasi tim:** Memanfaatkan aplikasi komunikasi digital agar staf dapat berbagi informasi penting secara instan dan aman, mengurangi kesalahan informasi.
- c. **Sistem manajemen inventaris digital:** Memastikan logistik dan peralatan medis tersedia secara tepat waktu, meminimalkan kekurangan atau kelebihan persediaan.

Implementasi strategi praktis ini secara konsisten akan membantu menciptakan alur kerja yang efisien, memastikan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta memudahkan manajemen dalam membuat keputusan berbasis data secara cepat dan tepat.

E. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun datang ke UGD dengan keluhan demam tinggi, sesak napas, dan batuk berdarah sejak 2 hari lalu. Riwayat diabetes mellitus sudah 5 tahun. Hasil saturasi oksigen menunjukkan angka 88%. Apa tindakan triase yang tepat pada pasien ini?
 - A. Pasien ditempatkan di zona hijau
 - B. Pasien diberikan APD dan diminta menunggu di ruang tunggu umum
 - C. Pasien segera ditempatkan di zona kuning
 - D. Pasien langsung ditempatkan di zona merah dan diberikan oksigen
 - E. Pasien diarahkan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium di luar fasilitas

Jawaban: D

Pembahasan: Pasien menunjukkan tanda klinis berat (saturasi oksigen rendah 88%, demam, sesak napas) dengan komorbid diabetes mellitus, sehingga memerlukan perawatan intensif segera di zona merah untuk memastikan pengawasan ketat dan pemberian oksigen.

2. Seorang perawat baru bergabung dalam tim penanganan COVID-19 dan akan ditugaskan di zona merah. Tindakan manajerial apa yang paling tepat untuk memastikan perawat siap secara maksimal?
 - A. Langsung menugaskan perawat tersebut di zona merah

- B. Memberikan pelatihan mendalam mengenai prosedur isolasi dan penggunaan APD
- C. Menjadwalkan perawat pada shift yang paling padat
- D. Memberikan tugas administrasi terlebih dahulu
- E. Mengadakan pertemuan tim mingguan saja tanpa pelatihan tambahan

Jawaban: B

Pembahasan: Pelatihan mendalam mengenai prosedur isolasi dan penggunaan APD sebelum bertugas sangat penting untuk memastikan keamanan perawat baru, mengurangi risiko transmisi, serta meningkatkan rasa percaya diri tenaga kesehatan.

3. Dalam evaluasi rutin, ditemukan peningkatan waktu tunggu pasien di zona kuning dari rata-rata 20 menit menjadi 45 menit. Langkah awal manajemen yang harus dilakukan adalah:
- A. Mengabaikan karena dianggap fluktuasi wajar
 - B. Menambah jumlah tenaga administrasi
 - C. Melakukan audit klinis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab
 - D. Langsung memindahkan beberapa pasien ke zona hijau
 - E. Mengurangi jumlah pasien masuk ke zona kuning

Jawaban: C

Pembahasan: Langkah awal yang tepat adalah melakukan audit klinis untuk mengetahui akar masalah peningkatan waktu tunggu, sehingga tindakan perbaikan yang sesuai dapat diimplementasikan.

4. Setelah evaluasi ditemukan beberapa tenaga kesehatan menunjukkan gejala burnout akibat jadwal kerja yang sangat padat. Strategi terbaik yang dapat dilakukan manajer keperawatan untuk mengatasi hal ini adalah:
- A. Menambah tugas administratif di luar jam kerja
 - B. Mengurangi jumlah hari libur tenaga kesehatan
 - C. Memperketat pengawasan pada tenaga kesehatan
 - D. Menyusun ulang jadwal kerja dengan rotasi yang efektif dan waktu istirahat cukup
 - E. Memberikan sanksi bagi tenaga kesehatan yang melaporkan burnout

Jawaban: D

Pembahasan: Penyusunan ulang jadwal kerja dengan rotasi efektif dan waktu istirahat cukup sangat penting untuk mengatasi burnout dan menjaga kesehatan mental serta fisik tenaga kesehatan.

5. Sebuah rumah sakit mengalami kekurangan APD di zona merah karena kesalahan perhitungan persediaan. Apa langkah manajemen logistik yang harus segera dilakukan agar masalah ini tidak terulang?
- A. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang bertugas
 - B. Membatasi pasien yang dapat dirawat
 - C. Membuat sistem manajemen inventaris digital yang memantau stok secara real-time
 - D. Membeli APD dalam jumlah besar secara mendadak tanpa perencanaan
 - E. Menyerahkan sepenuhnya masalah logistik ke tenaga kesehatan

Jawaban: C

Pembahasan: Implementasi sistem manajemen inventaris digital membantu pemantauan real-time terhadap ketersediaan APD sehingga masalah kekurangan persediaan dapat dicegah melalui perencanaan yang lebih efektif.

F. Rangkuman Materi

Manajemen alur kerja dalam penanganan pasien COVID-19 memerlukan pendekatan sistematis dan terstruktur, dimulai dengan triase yang tepat untuk menentukan prioritas layanan berdasarkan kondisi klinis pasien, seperti suhu tubuh, saturasi oksigen, dan gejala pernapasan, serta mempertimbangkan riwayat penyakit kronis yang dimiliki pasien. Metode triase yang efektif membantu mencegah penumpukan pasien di fasilitas kesehatan sekaligus mengurangi risiko transmisi antar pasien maupun tenaga kesehatan.

Zonasi perawatan menjadi langkah penting berikutnya dengan menetapkan area terpisah berdasarkan status infeksi pasien, yaitu zona merah untuk pasien terkonfirmasi positif, zona kuning untuk pasien suspect atau dalam pengamatan, dan zona hijau untuk pasien negatif atau tanpa gejala. Setiap zona memiliki protokol khusus, jalur akses terpisah, dan prosedur desinfeksi ketat untuk memastikan keamanan pasien serta tenaga kesehatan.

Dalam manajemen tenaga kesehatan, penting untuk mengalokasikan perawat dan dokter sesuai kompetensi dan pengalaman mereka. Tenaga kesehatan berpengalaman ditempatkan di zona dengan risiko tinggi seperti zona merah, sedangkan yang memiliki kompetensi dasar atau administratif bertugas di area dengan risiko lebih rendah. Penjadwalan dan rotasi kerja yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kelelahan berlebih (burnout) dan mempertahankan kondisi fisik serta mental tenaga kesehatan.

Pengelolaan logistik dan peralatan medis merupakan komponen penting lainnya yang mencakup perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pemantauan alat

kesehatan seperti APD, ventilator, obat-obatan, dan oksigen. Sistem inventaris yang optimal serta pemeliharaan peralatan medis rutin akan memastikan operasional fasilitas kesehatan tetap aman dan efisien.

Pengelolaan tim keperawatan melibatkan komunikasi efektif melalui briefing dan debriefing harian, penggunaan teknologi komunikasi digital, koordinasi tugas yang jelas berbasis kompetensi, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi seperti rekam medis elektronik, laporan kondisi pasien secara digital, dan manajemen inventaris digital menjadi penunjang efektivitas pelayanan. Pelatihan rutin tentang penggunaan APD dan protokol kesehatan terbaru juga penting untuk menjamin kesiapan dan keamanan tenaga kesehatan.

Evaluasi efektivitas pengaturan alur kerja dilakukan melalui indikator seperti waktu tunggu pasien, tingkat kepuasan pasien dan tenaga kesehatan, serta kejadian infeksi nosokomial. Metode evaluasi mencakup audit klinis rutin, survei kepuasan secara berkala, pertemuan rutin dengan staf untuk memperoleh umpan balik, dan analisis data komprehensif. Evaluasi ini kemudian menjadi dasar implementasi tindakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus.

Implementasi praktis strategi alur kerja meliputi zonasi terorganisasi, penjadwalan tim dengan rotasi efektif, peningkatan kualitas pelatihan dan edukasi, serta pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Keseluruhan strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, akan menciptakan sistem pelayanan keperawatan yang efektif, responsif, aman, dan adaptif, khususnya selama pandemi COVID-19.

G. Glosarium

Alat Pelindung Diri (APD): Perlengkapan khusus yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan infeksi, terutama virus COVID-19.

Audit Klinis: Proses evaluasi sistematis terhadap kualitas layanan klinis dan kepatuhan terhadap prosedur yang bertujuan meningkatkan pelayanan pasien.

Briefing dan Debriefing: Pertemuan rutin yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas pelayanan kesehatan untuk membahas rencana kerja harian, evaluasi pelaksanaan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan.

Burnout: Kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan yang umum terjadi di kalangan tenaga kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19.

Evaluasi Efektivitas: Proses sistematis untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan pelayanan kesehatan tercapai berdasarkan indikator tertentu, seperti waktu tunggu pasien, tingkat kepuasan pasien dan staf, serta kejadian infeksi nosokomial.

Infeksi Nosokomial: Infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan akibat transmisi mikroorganisme, termasuk virus COVID-19, yang berasal dari lingkungan rumah sakit.

Kompetensi Tenaga Kesehatan: Kemampuan spesifik yang dimiliki oleh tenaga kesehatan berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan keahlian klinis yang dimiliki.

Manajemen Inventaris Digital: Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola stok peralatan medis dan logistik secara real-time, memastikan ketersediaan yang memadai.

Pengambilan Keputusan Kolaboratif: Proses pengambilan keputusan dalam tim secara bersama-sama melalui diskusi terbuka, yang melibatkan seluruh anggota tim kesehatan dengan berbagai latar belakang dan keahlian.

Protokol Kesehatan: Pedoman standar yang diterapkan untuk mencegah penyebaran infeksi, seperti penggunaan APD, desinfeksi lingkungan, dan langkah-langkah isolasi.

Rekam Medis Elektronik (EMR): Sistem digital untuk mendokumentasikan riwayat kesehatan pasien secara cepat dan akurat, memungkinkan akses mudah oleh tim pelayanan kesehatan secara real-time.

Rotasi Kerja: Sistem penjadwalan yang memungkinkan tenaga kesehatan mendapatkan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, mencegah kelelahan berlebih, serta menjaga performa optimal.

Saturasi Oksigen: Ukuran kadar oksigen yang terdapat dalam darah, indikator penting untuk menentukan tingkat keparahan gangguan pernapasan pada pasien COVID-19.

Sistem Triase: Prosedur untuk menentukan prioritas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien secara cepat dan efisien.

Transmisi Silang: Penularan infeksi antara pasien atau antara pasien dan tenaga kesehatan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Zonasi Perawatan: Pengelompokan area di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat risiko infeksi pasien, yang bertujuan untuk mengendalikan transmisi infeksi secara efektif.

H. Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Liu, Q., Luo, D., Haase, J. E., Guo, Q., Wang, X. Q., Liu, S., ... & Yang, B. X. (2022). The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: A

- qualitative study. *Lancet Global Health*, 10(6), e801–e808. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00004-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00004-6)
- World Health Organization. (2021). Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed. *WHO Interim Guidance*. Retrieved from [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-coronavirus-disease-\(covid-19\)-is-suspected-or-confirmed](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-coronavirus-disease-(covid-19)-is-suspected-or-confirmed)
- Rahman, H. A., Issa, W. B., Naing, L., & Abdullah, M. S. (2021). Role of triage in emergency departments during COVID-19 pandemic: A review. *International Journal of Emergency Medicine*, 14(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s12245-021-00334-5>
- Al Thobaity, A., & Alshammari, F. (2020). Nurses on the frontline against the COVID-19 pandemic: An integrative review. *Dubai Medical Journal*, 3(3), 87–92. <https://doi.org/10.1159/000509361>
- Gómez-Ochoa, S. A., Franco, O. H., Rojas, L. Z., Raguindin, P. F., Roa-Díaz, Z. M., Wyssmann, B. M., ... & Muka, T. (2021). COVID-19 in healthcare workers: A living systematic review and meta-analysis of prevalence, risk factors, clinical characteristics, and outcomes. *American Journal of Epidemiology*, 190(1), 161–175. <https://doi.org/10.1093/aje/kwaa191>
- Singh, H., Tang, T., Thombs, R., Armas, A., Nie, J. X., Nelson, M. L. A., & Gilca, V. (2021). Methodological considerations for evaluating health system interventions during the COVID-19 pandemic: Lessons learned from a rapid literature review. *Frontiers in Public Health*, 9, 678859. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.678859>

BAB 3

ADAPTASI INTRAPERSONAL DAN MENGELOLA EMOSI DALAM MENANGANI BURNOUT UNTUK PASIEN COVID-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan luar biasa dalam layanan kesehatan, khususnya bagi tenaga keperawatan. Beban kerja meningkat secara drastis, risiko infeksi yang tinggi, dan tekanan emosional yang signifikan menciptakan kondisi ideal bagi terjadinya burnout. Buku ajar ini bertujuan memberikan panduan bagi perawat tentang adaptasi intrapersonal dan pengelolaan emosi guna mempertahankan performa kerja serta menjaga kesehatan mental selama pandemi Covid-19.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran dari buku ini, lulusan mampu mengelola adaptasi intrapersonal dan emosi untuk mencegah burnout secara efektif dalam perawatan pasien Covid-19, dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang tepat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep adaptasi intrapersonal, mengelola emosi secara efektif, dan menerapkan strategi yang tepat dalam menangani burnout pada perawat selama pandemi Covid-19.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu memahami konsep adaptasi intrapersonal dalam konteks keperawatan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda burnout dalam konteks layanan kesehatan Covid-19.
- Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengelolaan emosi dalam situasi stres tinggi.
- Mahasiswa mampu menerapkan strategi praktis dalam manajemen burnout melalui adaptasi intrapersonal dan pengelolaan emosi.

Uraian Materi

A. Adaptasi Intrapersonal

Adaptasi intrapersonal merupakan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal dengan mekanisme koping yang efektif. Dalam konteks keperawatan Covid-19, adaptasi intrapersonal mencakup tiga aspek penting berikut:

1. Kesadaran Diri (Self-Awareness)

Kesadaran diri adalah kemampuan mengenali dan memahami secara mendalam kondisi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang. Dalam konteks keperawatan Covid-19, kesadaran diri membantu perawat untuk memahami dampak psikologis dari pekerjaan yang intens, seperti:

- a. **Mengenali tanda burnout:** Gejala-gejala awal seperti kelelahan emosional, frustrasi, insomnia, atau bahkan perubahan pola makan dapat segera diidentifikasi.
- b. **Refleksi pribadi rutin:** Melakukan refleksi atau evaluasi diri secara rutin, baik melalui jurnal harian atau sesi diskusi terbuka, untuk mengidentifikasi perasaan atau perubahan yang dialami.
- c. **Memahami batasan pribadi:** Mengetahui kapasitas diri dalam menghadapi beban kerja dan tidak ragu untuk meminta bantuan ketika merasa tertekan atau kewalahan.

2. Pengelolaan Stres (Stress Management)

Stres merupakan realitas tak terhindarkan dalam dunia keperawatan. Strategi efektif dalam mengelola stres sangat diperlukan agar perawat tetap produktif dan sehat secara emosional maupun fisik. Beberapa teknik pengelolaan stres yang sangat direkomendasikan antara lain:

- a. **Relaksasi Progresif:** Melibatkan teknik relaksasi otot secara bertahap, dimulai dari kelompok otot besar hingga kecil, yang efektif dalam mengurangi ketegangan fisik dan psikologis.
- b. **Meditasi Mindfulness:** Mengarahkan perhatian pada kondisi sekarang tanpa penilaian, membantu perawat lebih tenang, meningkatkan konsentrasi, serta mengurangi kecemasan berlebihan.
- c. **Latihan Pernapasan:** Latihan pernapasan mendalam secara rutin membantu meredakan respons fisiologis terhadap stres, memperlambat detak jantung, dan menenangkan pikiran.
- d. **Aktivitas Fisik Teratur:** Olahraga rutin seperti berjalan, jogging, yoga, atau latihan kekuatan membantu merilis hormon endorfin yang meningkatkan mood dan mengurangi stres.

3. Pengembangan Resiliensi

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih kembali dari situasi stres, tantangan, atau trauma. Perawat yang memiliki tingkat resiliensi tinggi umumnya lebih efektif dalam menghadapi tekanan kerja Covid-19. Beberapa strategi untuk membangun dan meningkatkan resiliensi antara lain:

- a. **Membangun Koneksi Sosial:** Dukungan emosional dari kolega, keluarga, atau kelompok dukungan profesional sangat penting dalam membantu perawat mengatasi perasaan isolasi dan tekanan emosional.
- b. **Pemikiran Positif (Positive Thinking):** Mendorong sikap positif melalui self-talk yang membangun, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, serta menerima tantangan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- c. **Meningkatkan Keterampilan Koping:** Praktikkan metode koping seperti pemecahan masalah yang sistematis, pengaturan waktu yang efisien, serta pengambilan keputusan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi tekanan kerja.

B. Mengelola Emosi dalam Menangani Burnout

Burnout dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, emosional, produktivitas, serta kualitas layanan kesehatan. Berikut strategi detail untuk mengelola emosi dalam mengatasi burnout:

1. Pengaturan Emosi (Emotion Regulation)

Pengaturan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, serta mengelola emosinya secara efektif. Dalam konteks pandemi Covid-19, teknik berikut sangat penting:

- a. **Cognitive Reframing (Restrukturisasi Kognitif)** Cognitive reframing membantu perawat mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Misalnya, saat menghadapi situasi sulit seperti jumlah pasien yang meningkat tajam, perawat dapat memandang situasi tersebut sebagai tantangan profesional yang meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, bukan sebagai beban yang tidak tertangani.
- b. **Mindfulness Emotional Regulation** Praktik mindfulness memungkinkan perawat untuk mengamati emosi yang muncul tanpa penilaian. Dengan mempraktikkan mindfulness, perawat mampu mengurangi reaksi negatif terhadap stres dan meningkatkan kemampuan mereka untuk tetap tenang di bawah tekanan, sehingga keputusan klinis yang lebih baik bisa diambil.
- c. **Ekspresi Emosi yang Sehat** Penting bagi perawat untuk menemukan cara yang tepat dalam mengekspresikan emosi mereka, misalnya melalui diskusi

terbuka, konseling profesional, atau menulis jurnal harian. Hal ini membantu mencegah penumpukan emosi negatif yang dapat berujung pada burnout.

2. Support Sosial

Dukungan sosial dari berbagai sumber merupakan komponen vital dalam mengelola burnout. Bentuk dukungan tersebut meliputi:

- a. **Emotional Support** Dukungan emosional berupa empati, pemahaman, dan perhatian dari rekan kerja atau keluarga membantu perawat merasa didengar dan dimengerti. Hal ini mampu mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan rasa percaya diri perawat dalam menghadapi tekanan kerja.
- b. **Instrumental Support** Bantuan praktis seperti bantuan dalam menyelesaikan tugas, pembagian beban kerja yang adil, serta fleksibilitas jadwal kerja sangat membantu mengurangi beban fisik dan mental perawat.
- c. **Informational Support** Dukungan berupa pemberian informasi jelas dan arahan yang efektif sangat membantu perawat dalam mengelola tantangan kerja. Misalnya, pelatihan mengenai teknik pengelolaan stres dan panduan klinis yang jelas dalam menangani pasien Covid-19.
- d. **Kelompok Dukungan Profesional** Penyediaan forum atau kelompok diskusi yang rutin diadakan oleh institusi kesehatan, memungkinkan perawat berbagi pengalaman, tantangan, solusi, serta mendukung satu sama lain secara emosional dan profesional dalam suasana yang kondusif.

3. Self-Care dan Work-Life Balance

Praktik perawatan diri dan menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi penting untuk memulihkan kondisi emosional perawat dan mencegah burnout. Strategi efektif meliputi:

- a. **Aktivitas Relaksasi** Teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau latihan pernapasan membantu meredakan stres dengan meningkatkan respons relaksasi tubuh serta membantu perawat mendapatkan ketenangan mental.
- b. **Aktivitas Fisik Teratur** Kegiatan fisik rutin seperti berjalan kaki, jogging, atau berenang dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kebugaran fisik.
- c. **Tidur yang Cukup** Menjaga pola tidur teratur dengan durasi yang cukup penting untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Tidur yang baik membantu meningkatkan kemampuan kognitif, regulasi emosi, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres.
- d. **Membatasi Waktu Kerja** Menentukan batasan jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi membantu mencegah kelelahan kronis. Mengatur waktu istirahat yang efektif di sela-sela tugas memungkinkan perawat untuk pulih secara fisik dan mental.

- e. **Mengembangkan Hobi dan Minat** Melibatkan diri dalam kegiatan yang disukai di luar lingkungan kerja membantu perawat mengalihkan perhatian dari tekanan kerja, meredakan stres, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup.

C. Implementasi Strategi Adaptasi dan Pengelolaan Emosi

Implementasi strategi adaptasi intrapersonal dan pengelolaan emosi memerlukan pendekatan komprehensif yang didukung oleh institusi kesehatan. Beberapa langkah penting dalam implementasi strategi tersebut meliputi:

1. Program Pelatihan Regulasi Emosi

Program pelatihan regulasi emosi dirancang untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat dan konstruktif. Program ini mencakup:

- a. **Pelatihan Mindfulness dan Relaksasi:** Pelatihan ini bertujuan membangun kebiasaan mindfulness, yang membantu perawat menjadi lebih sadar terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Teknik-teknik relaksasi progresif seperti meditasi mindfulness, latihan pernapasan dalam, dan yoga membantu mengurangi kecemasan dan stres, meningkatkan ketenangan, serta meningkatkan daya konsentrasi dalam situasi kerja yang penuh tekanan.
- b. **Workshop Cognitive Reframing:** Melalui cognitive reframing, perawat diajarkan untuk mengenali pikiran negatif otomatis dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Teknik ini efektif untuk membantu perawat menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan objektif, serta mengurangi dampak negatif dari stres kerja.
- c. **Pelatihan Keterampilan Komunikasi Asertif:** Keterampilan komunikasi asertif membantu perawat untuk mengekspresikan kebutuhan, perasaan, dan harapan secara jelas, terbuka, dan sopan tanpa menimbulkan konflik atau perasaan tidak nyaman. Pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan perawat dalam mengelola konflik interpersonal yang sering terjadi di lingkungan kerja.

2. Kelompok Dukungan dan Konseling Profesional

Institusi harus aktif menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial dan profesional untuk membantu perawat mengatasi tekanan emosional akibat pandemi Covid-19. Bentuk-bentuk dukungan tersebut meliputi:

- a. **Kelompok Dukungan Peer:** Membentuk kelompok diskusi reguler yang memungkinkan perawat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam suasana yang mendukung. Kelompok ini memberikan rasa solidaritas dan mengurangi rasa isolasi yang sering dirasakan oleh perawat.

- b. **Sesi Konseling Profesional:** Menyediakan layanan konseling profesional secara rutin dan terstruktur. Konseling ini dilakukan oleh psikolog atau konselor profesional yang membantu perawat dalam mengatasi masalah pribadi maupun profesional secara efektif dan konstruktif.
- c. **Pelayanan Kesehatan Mental Online:** Institusi kesehatan menyediakan platform online yang memungkinkan perawat mendapatkan akses konseling mental secara fleksibel dan cepat. Platform ini dapat berupa aplikasi atau layanan berbasis website yang memberikan privasi serta kenyamanan dalam konsultasi.

3. Kebijakan Jam Kerja Fleksibel dan Rotasi Tugas

Kebijakan terkait jam kerja dan rotasi tugas dirancang untuk mengurangi kelelahan fisik dan mental perawat. Implementasi efektif dari kebijakan ini mencakup:

- a. **Jam Kerja Fleksibel:** Menyediakan opsi jam kerja yang fleksibel memungkinkan perawat mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan pribadi dan keluarga, membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.
- b. **Rotasi Tugas secara Teratur:** Sistem rotasi tugas yang teratur membantu perawat menghindari kejenuhan serta kelelahan akibat tugas yang monoton. Rotasi juga meningkatkan keterampilan klinis melalui variasi pengalaman di berbagai unit atau tugas.
- c. **Pengaturan Waktu Istirahat yang Efektif:** Institusi harus memastikan bahwa perawat memiliki waktu istirahat yang cukup selama jam kerja untuk memulihkan energi fisik dan mental. Jadwal istirahat yang teratur juga membantu menjaga produktivitas dan kesehatan perawat.

D. Latihan Soal

1. Seorang Perawat bekerja di unit isolasi COVID-19 selama dua bulan. Akhir-akhir ini ia merasa sangat lelah, frustrasi, dan mulai mengalami insomnia. Ia menyadari kondisinya, namun bingung tindakan apa yang harus dilakukan pertama kali. Langkah adaptasi intrapersonal yang paling tepat untuk dilakukan perawat tersebut adalah:
 - A. Meningkatkan aktivitas fisik berat untuk melupakan masalah
 - B. Mengabaikan perasaan tersebut agar segera berlalu
 - C. Mengurangi jam istirahat agar terbiasa dengan kondisi kerja berat
 - D. Melakukan refleksi pribadi secara rutin melalui jurnal atau diskusi terbuka
 - E. Menambah jam kerja agar perasaan bersalah berkurang

Jawaban: D

Pembahasan: Melakukan refleksi pribadi membantu Mira untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan serta kondisinya secara mendalam agar langkah selanjutnya bisa direncanakan dengan tepat.

2. Seorang Perawat mulai merasa kewalahan dengan beban kerja yang semakin bertambah di masa pandemi. Ia sering marah tanpa alasan jelas. Berdasarkan strategi pengaturan emosi, tindakan yang paling tepat bagi perawat tersebut adalah:
- A. Menyimpan emosinya sendiri tanpa dibagikan pada siapa pun
 - B. Menggunakan teknik cognitive reframing untuk melihat beban kerja sebagai tantangan profesional
 - C. Mengambil cuti panjang tanpa komunikasi lebih lanjut
 - D. Meminta untuk dipindahkan ke unit yang lebih ringan
 - E. Menyelesaikan semua tugas dalam satu waktu agar tidak menumpuk

Jawaban: B

Pembahasan: Cognitive reframing membantu Dito merubah pola pikir negatif menjadi positif, melihat beban kerja sebagai tantangan yang meningkatkan keterampilan profesional.

3. Seorang perawat mengalami stres tinggi karena rutinitas pekerjaan selama pandemi. Teknik relaksasi paling efektif yang dapat direkomendasikan kepada perawat tersebut untuk mengelola stresnya adalah:
- A. Menyelesaikan tugas-tugas tambahan agar lupa stres
 - B. Menonton acara TV favorit sepanjang malam
 - C. Melakukan relaksasi progresif secara rutin
 - D. Menghindari interaksi sosial agar tidak terganggu
 - E. Tidur lebih sedikit agar tidak memikirkan masalah

Jawaban: C

Pembahasan: Relaksasi progresif efektif untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis dengan merilekskan otot secara bertahap.

4. Seorang perawat merasa terisolasi secara emosional karena tekanan pekerjaan di masa pandemi. Strategi paling tepat yang dapat dilakukan perawat tersebut untuk meningkatkan resiliensi adalah:
- A. Mengurangi komunikasi dengan keluarga agar tidak menambah beban
 - B. Mengandalkan dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah

- C. Membangun koneksi sosial dengan rekan kerja atau kelompok dukungan profesional
- D. Berhenti sementara dari pekerjaannya
- E. Meningkatkan jam tidur secara drastis

Jawaban: C

Pembahasan: Membangun koneksi sosial dapat mengurangi rasa isolasi emosional dan meningkatkan resiliensi dengan memperoleh dukungan emosional yang kuat.

5. Seorang perawat mengalami burnout akibat jadwal kerja yang padat selama menangani pasien COVID-19. Langkah paling tepat bagi institusi untuk mendukung perawat tersebut adalah:
- A. Menambah beban kerja agar terbiasa dengan tekanan tinggi
 - B. Mengatur jam kerja fleksibel dan waktu istirahat yang efektif
 - C. Memberikan tugas tambahan agar tidak fokus pada kelelahan
 - D. Menyuruh Rina mencari solusi sendiri
 - E. Menyarankan Rina mengurangi interaksi sosial

Jawaban: B

Pembahasan: Institusi bertanggung jawab menyediakan jam kerja fleksibel dan waktu istirahat efektif sebagai bagian penting dari dukungan instrumental dalam mengurangi risiko burnout.

E. Rangkuman latihan

Adaptasi intrapersonal adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal menggunakan mekanisme koping yang efektif. Dalam konteks keperawatan Covid-19, kemampuan ini sangat penting bagi perawat agar mampu mengatasi tekanan psikologis akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi. Kesadaran diri merupakan bagian penting dari adaptasi intrapersonal, memungkinkan perawat mengenali emosi, pikiran, serta perilaku yang dipengaruhi oleh stres pekerjaan. Melalui refleksi diri secara rutin, perawat dapat segera mengidentifikasi tanda awal burnout, seperti kelelahan emosional, insomnia, atau perubahan pola makan, dan memahami batas-batas kapasitas pribadi untuk meminta bantuan tepat waktu.

Selain kesadaran diri, pengelolaan stres juga merupakan aspek vital dalam menjaga kesehatan mental dan fisik perawat. Berbagai teknik pengelolaan stres seperti relaksasi progresif, meditasi mindfulness, latihan pernapasan mendalam, dan aktivitas fisik yang rutin sangat dianjurkan karena mampu secara signifikan mengurangi respons negatif terhadap stres serta meningkatkan keseimbangan

emosional. Pengembangan resiliensi juga esensial, yaitu kemampuan untuk bertahan dan cepat pulih dari situasi stres atau trauma. Strategi efektif dalam meningkatkan resiliensi meliputi membangun koneksi sosial yang kuat, menerapkan pemikiran positif secara konsisten, serta meningkatkan keterampilan koping seperti pemecahan masalah, pengelolaan waktu, dan pengambilan keputusan secara jelas dan sistematis.

Burnout, yang sering dihadapi perawat selama pandemi, dapat dikendalikan melalui pengaturan emosi yang efektif, termasuk restrukturisasi kognitif dan mindfulness emotional regulation. Strategi ini membantu perawat mengubah pandangan negatif terhadap tantangan kerja menjadi peluang untuk tumbuh secara profesional serta menjaga kestabilan emosional dengan cara yang sehat, seperti ekspresi emosi secara terbuka atau melalui konseling. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar, baik secara emosional, instrumental, maupun informasional, menjadi fondasi penting dalam mengelola burnout, dilengkapi dengan kelompok dukungan profesional yang memfasilitasi interaksi antar perawat untuk saling menguatkan.

Praktik perawatan diri melalui aktivitas relaksasi, olahraga rutin, tidur cukup, membatasi waktu kerja secara jelas, serta mengembangkan hobi juga menjadi strategi esensial untuk mencegah burnout dan meningkatkan kesejahteraan emosional perawat. Dalam implementasi strategi adaptasi intrapersonal ini, institusi kesehatan memiliki peran besar melalui program pelatihan regulasi emosi, penyediaan kelompok dukungan dan konseling profesional secara terstruktur, serta penerapan kebijakan jam kerja fleksibel dan rotasi tugas yang teratur guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional para perawat.

F. Glosarium

Adaptasi Intrapersonal: Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri secara efektif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui mekanisme koping yang tepat.

Burnout: Kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tekanan pekerjaan yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja dan kesehatan individu.

Cognitive Reframing (Restrukturisasi Kognitif): Teknik mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif dengan melihat tantangan sebagai peluang belajar dan pengembangan diri.

Ekspresi Emosi yang Sehat: Cara individu dalam mengungkapkan emosi secara konstruktif dan terbuka, seperti melalui diskusi, konseling, atau menulis jurnal, untuk mencegah akumulasi emosi negatif.

Kesadaran Diri (Self-Awareness): Kemampuan mengenali dan memahami kondisi emosional, pikiran, serta perilaku diri sendiri secara mendalam untuk mengelola dampak psikologis pekerjaan secara efektif.

Keterampilan Komunikasi Asertif: Kemampuan mengekspresikan kebutuhan, perasaan, dan harapan secara jelas, terbuka, dan sopan tanpa menimbulkan konflik.

Koneksi Sosial: Hubungan emosional yang kuat dengan kolega, keluarga, atau kelompok dukungan yang membantu mengurangi rasa isolasi dan tekanan emosional.

Koping: Strategi atau cara individu dalam menghadapi tantangan, stres, atau situasi sulit untuk meminimalkan dampak negatif secara emosional maupun fisik.

Meditasi Mindfulness: Praktik meditasi yang memfokuskan perhatian pada saat ini secara sadar dan tanpa penilaian, untuk mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, serta memperkuat regulasi emosi.

Pengelolaan Stres: Teknik atau strategi untuk mengatasi stres secara efektif guna menjaga kesehatan emosional dan fisik.

Resiliensi: Kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, dan cepat pulih kembali dari situasi stres atau trauma.

Rotasi Tugas: Pengaturan penugasan kerja yang dilakukan secara bergantian di berbagai unit atau tugas guna mencegah kejenuhan serta meningkatkan keterampilan klinis perawat.

Self-Care: Praktik perawatan diri yang meliputi aktivitas relaksasi, olahraga rutin, tidur cukup, serta keterlibatan dalam hobi untuk menjaga keseimbangan emosional dan mencegah burnout.

Work-Life Balance: Keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi yang membantu individu dalam mencegah kelelahan kronis dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

G. Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (n.d.). *Resilience*. In APA Dictionary of Psychology. Retrieved Month Day, Year, from <https://www.apa.org/topics/resilience>
en.wikipedia.org+4[apa.org](https://www.apa.org)+4[self.com](https://www.self.com)+4
- Hosseini Moghaddam, M., Mohebbi, Z., & Tehranineshat, B. (2022). *Stress management in nurses caring for COVID-19 patients: A qualitative content analysis*. BMC Psychology, 10, 124.

<https://doi.org/10.1186/s40359-022-00834-4>
bmcp psychology.biomedcentral.com

- Kabat-Zinn, J. (1982). *An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results*. *General Hospital Psychiatry*, 4(1), 33–47.
- Shahrour, G., & Dardas, L. A. (2020). Acute stress disorder, coping self-efficacy and subsequent psychological distress among nurses amid COVID-19. *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1686–1695.
<https://doi.org/10.1111/jonm.13124> pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Shechter, A., Diaz, F., Moise, N., Anstey, D. E., Ye, S., Agarwal, S., et al. (2020). Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *General Hospital Psychiatry*, 66, 1–8.
[researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/354111111)+7pmc.ncbi.nlm.nih.gov+7pmc.ncbi.nlm.nih.gov+7
- Smith, B. W., et al. (2021). Nurses' resilience in the face of coronavirus (COVID-19): A survey of 904 nurses across four countries. *International Journal of Nursing Practice*, 27(5), e12923. <https://doi.org/10.1111/ijn.12923> pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). *Posttraumatic growth: Conceptual foundation and empirical evidence*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Wiig, S. (2022). *The relations between resilience and self-efficacy among healthcare practitioners in context of the COVID-19 pandemic: A rapid review*. Centre for Resilience in Healthcare, University of Stavanger.
[en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic)+15researchgate.net+15pmc.ncbi.nlm.nih.gov+15

BAB 4

FUNGSI PENGARAHAN

Pendahuluan

Manajemen merupakan tulang punggung dari setiap organisasi, baik itu perusahaan besar, lembaga pendidikan, maupun organisasi nirlaba. Dalam mencapai tujuan organisasi, fungsi-fungsi manajemen memainkan peran krusial. Salah satu fungsi yang sangat penting adalah fungsi pengarahan (*directing* atau *actuating*). Fungsi ini tidak hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi juga melibatkan upaya untuk memotivasi, membimbing, dan menginspirasi anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Fungsi pengarahan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan. Tanpa pengarahan yang tepat, rencana yang telah disusun dengan matang dan struktur organisasi yang telah dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fungsi pengarahan sangat penting bagi para pemimpin dan manajer di semua tingkatan.

Dalam materi ajar ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari fungsi pengarahan. Dengan memahami dan menerapkan fungsi pengarahan secara efektif, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dan mengelola tim, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.

Tujuan Instruksional:

Tujuan instruksional umum

Mahasiswa mampu memahami fungsi pengarahan dalam penerapan kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan keperawatan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

- Memahami definisi dan tujuan fungsi pengarahan.
- Memahami pentingnya pengarahan dalam manajemen keperawatan
- Memahami komponen-komponen utama fungsi pengarahan, seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi.
- Memahami jenis-jenis pengarahan
- Memahami metode pengarahan

- Memahami tantangan dalam pengarahan
- Memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas pengarahan
- Memahami prinsip pengarahan yang efektif

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis dan mengaplikasikan fungsi pengarahan dalam konteks praktik keperawatan profesional dalam kepemimpinan dan manajemen keperawatan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, yaitu:

- Menjelaskan konsep dasar fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan
- Mengidentifikasi komponen-komponen utama pengarahan
- Menganalisis penerapan fungsi pengarahan dalam konteks pelayanan keperawatan
- Mendemonstrasikan keterampilan pengarahan
- Menunjukkan sikap profesional dalam memimpin dan mengarahkan tim keperawatan

Uraian Materi

A. Definisi Pengarahan

Konsep pengarahan dalam manajemen keperawatan adalah salah satu fungsi penting dari manajemen yang fokus pada mengarahkan, membimbing, dan memotivasi perawat serta staf lainnya agar bekerja sesuai tujuan organisasi (biasanya rumah sakit atau fasilitas kesehatan) dan tetap memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas.

Pengarahan adalah usaha untuk memimpin, membimbing, dan mempengaruhi orang lain agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi." (Terry & Rue, 2019). Definisi ini menunjukkan bahwa pengarahan bukan sekadar memberi perintah, tapi juga membina dan memotivasi staf. Siagian (2014) menyebutkan bahwa Pengarahan adalah proses pemberian bimbingan, perintah, dan instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Secara keseluruhan, pengarahan dalam manajemen keperawatan adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan yang membutuhkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi yang kuat dari seorang manajer keperawatan.

B. Tujuan Fungsi Pengarahan

1. Memberikan arahan dan petunjuk yang jelas kepada staf.
2. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja staf.
3. Membangun komunikasi yang efektif antara manajer dan staf.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif.
5. Memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

C. Pentingnya pengarahan dalam manajemen keperawatan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja staf.
3. Menciptakan tim kerja yang solid dan efektif.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
5. Mencapai tujuan organisasi keperawatan.

D. Komponen Pengarahan

1. Motivasi

Mendorong staf perawat untuk memberikan kinerja terbaik melalui pengakuan, penghargaan, dan pengembangan karir.

2. Komunikasi

Memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif, serta mendengarkan masukan dari staf.

3. Kepemimpinan

Memberikan contoh yang baik, mengambil keputusan yang tepat, dan menginspirasi staf untuk mencapai tujuan bersama

4. Supervisi

Memantau dan mengevaluasi kinerja staf, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membantu mengatasi masalah yang muncul

5. Pendelegasian

Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada staf sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka

6. Manajemen konflik

Mampu menyelesaikan konflik yang terjadi didalam ruang lingkup kerja.

E. Jenis – Jenis Pengarahan

1. Pengarahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung dari metode dan pendekatannya:
2. Pengarahan Formal: Dilakukan secara resmi seperti briefing, rapat, atau instruksi tertulis.
3. Pengarahan Informal: Terjadi secara spontan, seperti saat berdiskusi santai atau percakapan singkat di ruang kerja.
4. Pengarahan Individual: Diberikan kepada staf secara perorangan, misalnya saat ada kesalahan kerja atau evaluasi pribadi.
5. Pengarahan Kelompok: Diberikan kepada tim atau unit kerja secara kolektif untuk menyatukan persepsi atau membahas masalah bersama.

F. Metode Pengarahan

1. Briefing rutin: Sebelum shift dimulai untuk menyampaikan informasi penting.
2. One-on-one coaching: Untuk staf yang memerlukan bimbingan khusus.
3. Rapat staf: Untuk menyampaikan kebijakan baru, evaluasi kinerja, atau pemecahan masalah bersama.
4. Observasi langsung: Untuk menilai dan mengarahkan praktik keperawatan secara real-time.

G. Tantangan dalam pengarahan

1. Resistensi staf terhadap arahan.
2. Beban kerja tinggi.

3. Perbedaan persepsi dan budaya kerja.
4. Kurangnya keterampilan komunikasi pimpinan.

H. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengarahan

1. Gaya kepemimpinan manajer : otoriter, demokratis, laissez-faire
2. Kemampuan komunikasi: verbal, non-verbal, dan kemampuan mendengar aktif.
3. Budaya organisasi: apakah mendorong keterbukaan atau tidak.
4. Kondisi emosional staf: stres, kelelahan, atau konflik memengaruhi penerimaan pengarahan.
5. Ketersediaan waktu dan media komunikasi

I. Prinsip pengarahan Efektif

1. Dilakukan secara komunikatif dan terbuka.
2. Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan staf.
3. Mudah dipahami dan pemilihan kata – kata yang tepat
4. Mengutamakan pendekatan humanis dan profesional.
5. Hindari memberikan banyak arahan pada satu waktu
6. Yakinkan kembali bahwa arahan dilaksanakan atau perlu tindak lanjut
7. Memberikan umpan balik yang membangun.

J. Latihan Soal

1. Jelaskan definisi pengarahan
2. Jelaskan komponen dalam fungsi pengarahan
3. Jelaskan pentingnya fungsi pengarahan dalam kegiatan perawat sehari-hari
4. Jelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas pengarahan
5. Sebutkan prinsip – prinsip pengarahan efektif

K. Rangkuman Materi

Fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan kegiatan keperawatan berjalan efektif dan efisien. Pengarahan didefinisikan sebagai proses membimbing, memotivasi, dan mengarahkan staf agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan utama pengarahan adalah meningkatkan kinerja staf, membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan motivasi dan disiplin kerja, serta menjamin bahwa pelayanan keperawatan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Komponen utama dalam fungsi pengarahan meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan supervisi. Pengarahan dapat dilakukan secara formal maupun informal, baik kepada individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, pengarahan sering menghadapi tantangan seperti resistensi dari staf, beban kerja

yang tinggi, serta kurangnya keterampilan komunikasi dari manajer, sehingga perlu diterapkan prinsip-prinsip agar pengarahan efektif antara lain pengarahan harus dilakukan secara terbuka, komunikatif, disesuaikan dengan kondisi staf, dan disertai dengan umpan balik yang membangun.

L. Glosarium

Briefing: Penyampaian informasi, instruksi atau pengarahan sebelum pelaksanaan tugas.

One-on-one coaching: metode pembinaan atau bimbingan individual antara atasan (misalnya kepala ruangan atau manajer keperawatan) dengan staf keperawatan tertentu secara langsung dan personal

Standar Operasional Prosedur (SOP): instruksi tertulis atau langkah – langkah suatu kegiatan yang dibakukan dan digunakan sebagai standar atau acuan agar kegiatan/ proses tertentu dapat dilakukan secara konsisten oleh setiap orang.

M. Daftar Pustaka

- Bakri, M. H. (2017). *Manajemen Keperawatan: Konsep dan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Pustaka Baru Press
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2017). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application* (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Nursalam. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Salemba Medika.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (cetakan 22). Bumi Aksara.
- Swansburg, R. J. (2006). *Introduction to Management and Leadership for Nurse Managers* (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Terry, George. R., & Rue, Leslie. W. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi* (B. S. Fatmawati, Ed.). Bumi Aksara.

BAB 5

PENGENDALIAN MUTU ASUHAN DAN PELAYANAN KEPERAWATAN

Pendahuluan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup upaya memastikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi. Dalam konteks ini, penjaminan mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga melibatkan manajemen, pasien, dan seluruh pihak terkait.

Asuhan keperawatan, sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, memiliki peranan penting dalam memastikan kualitas pelayanan. Melalui pendekatan berbasis standar praktik, pedoman klinis, dan kode etik profesi, asuhan keperawatan berfokus pada pemberian tindakan yang aman, efektif, dan manusiawi. Berbagai dimensi mutu, seperti efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepuasan pasien, menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pasien.

Penjaminan mutu asuhan keperawatan terus berkembang seiring dengan dinamika sistem kesehatan, teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis metode sistematis, seperti *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dan prinsip manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*), menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pelayanan. Melalui pembahasan ini, akan difokuskan pada konsep dasar penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, dimensi mutu pelayanan keperawatan, prinsip manajemen mutu terpadu, dan indikator mutu keperawatan

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dasar penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, dimensi mutu pelayanan keperawatan, prinsip manajemen mutu terpadu, dan indikator mutu keperawatan.

A. Pengertian Penjaminan Mutu Pelayanan Keperawatan

Penjaminan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mutu dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepuasan pasien (Azwar, 2019). Penjaminan mutu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan secara terus-menerus melalui pengukuran kinerja, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan kesehatan, manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan klinis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Potter & Perry, 2020).

Dalam asuhan keperawatan, penjaminan mutu memainkan peran yang sangat penting. Asuhan keperawatan adalah serangkaian tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien (Effendy, 2018). Penjaminan mutu asuhan keperawatan berfokus pada memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar praktik keperawatan, pedoman klinis, dan kode etik profesi (Burns & Grove, 2020). Hal ini mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi tindakan keperawatan untuk mencapai hasil yang optimal bagi pasien. Dengan adanya penjaminan mutu, perawat dapat memberikan asuhan yang aman, efektif, dan manusiawi.

Komponen utama penjaminan mutu asuhan keperawatan meliputi pengembangan standar mutu, pengukuran kinerja, pelatihan berkelanjutan, dan sistem pelaporan yang transparan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021), pengukuran kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai apakah asuhan keperawatan yang diberikan telah memenuhi indikator tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka langkah-langkah perbaikan segera diambil melalui pelatihan, supervisi, atau perubahan prosedur kerja.

Menurut Notoatmodjo (2021), penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan juga membutuhkan pendekatan multidisiplin. Hal ini berarti bahwa kerja sama antara dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan tenaga medis lainnya sangat diperlukan untuk memberikan perawatan yang terintegrasi. Dalam sistem kesehatan modern, pendekatan multidisiplin ini sering diterapkan melalui model

pelayanan berbasis tim, di mana setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas tetapi tetap berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik bagi pasien (Marquis & Huston, 2021). Salah satu metode yang banyak digunakan dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan adalah pendekatan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Metode ini terdiri dari empat tahap utama: (1) *Plan* (merencanakan perbaikan berdasarkan analisis masalah), (2) *Do* (melaksanakan rencana perbaikan), (3) *Check* (mengevaluasi hasil perbaikan), dan (4) *Act* (menindaklanjuti evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan). Pendekatan ini memungkinkan organisasi layanan kesehatan untuk terus memperbaiki mutu pelayanan secara dinamis dan adaptif (Glickman, 2007).

Selain itu, implementasi teknologi informasi juga menjadi salah satu pilar penting dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) memungkinkan pencatatan data pasien secara elektronik, pengelolaan obat, dan pemantauan indikator mutu secara *real-time* (JCI, 2021). Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja perawat, mengurangi risiko kesalahan medis, dan memudahkan koordinasi antarprofesi. Namun, penjaminan mutu tidak dapat berjalan tanpa adanya manajemen organisasi dan tenaga medis. Menurut Kohn (2000), budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) harus menjadi bagian integral dari organisasi pelayanan kesehatan. Semua pihak harus dilibatkan dalam proses ini, termasuk pasien dan keluarganya, melalui edukasi tentang hak-hak pasien, prosedur pelayanan, dan mekanisme pelaporan jika terjadi keluhan.

B. Fungsi dan Proses Sistem Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu dalam keperawatan melibatkan seluruh komponen dalam organisasi kesehatan, dari kebijakan, prosedur, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Fungsi pengendalian mutu dalam keperawatan meliputi beberapa aspek penting yang mendukung kualitas pelayanan kesehatan, antara lain:

1. Menjamin Kualitas Layanan

Pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh perawat memenuhi standar profesional yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini mencakup pemeriksaan kualitas perawatan yang diberikan, penilaian terhadap kompetensi perawat, serta pemantauan efektivitas terapi yang dilakukan (Jamilah & Wulandari, 2018).

2. Pemenuhan Standar Profesionalisme

Fungsi lainnya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan oleh

lembaga pendidikan dan organisasi profesi, serta hukum yang berlaku (Jamilah & Wulandari, 2018)

3. Evaluasi Kinerja Perawat

Pengendalian mutu juga melibatkan penilaian terhadap kinerja perawat dalam melaksanakan tugasnya. Proses ini dilakukan dengan melakukan audit mutu dan feedback yang konstruktif, guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan potensi perawat (Dewi & Santoso, 2016)

4. Meningkatkan Keamanan Pasien

Tujuan pengendalian mutu yakni untuk meningkatkan keselamatan pasien, dengan cara mengidentifikasi risiko-risiko yang membahayakan dan mengimplementasikan prosedur yang dapat meminimalkan kesalahan medis serta perawatan yang tidak tepat (Nursalam, 2013).

5. Perbaikan Berkelanjutan

Fungsi pengendalian mutu keperawatan juga mencakup perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) demi meningkatkan kualitas perawatan serta pelayanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya (Juran & Gryna, 1993).

Menurut Sukartini dan Sudiardja (2019), proses pada pengendalian mutu keperawatan terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses pertama dalam pengendalian mutu adalah perencanaan, di mana standar mutu dan prosedur yang harus dipatuhi ditetapkan. Pada tahap ini, dilakukan penentuan tujuan mutu yang spesifik dan terukur, seperti standar waktu pelayanan, kualitas perawatan, dan kepuasan pasien.

2. Pelaksanaan (*Implementation*)

Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan standar mutu yang telah ditentukan. Pelaksanaan ini melibatkan para tenaga perawat untuk menerapkan prosedur dan pedoman yang sudah ditetapkan dalam praktik sehari-hari. Pada tahap ini juga dilakukan edukasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua perawat memahami dan mematuhi standar yang ada.

3. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation*)

Setelah implementasi, tahap pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana standar mutu diterapkan. Hal ini dilakukan melalui audit, pengumpulan data, dan pemantauan kinerja perawat. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai dan apakah ada kekurangan dalam pelaksanaan.

4. Perbaikan (Corrective Actions)

Berdasarkan hasil evaluasi, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pelaksanaan, langkah perbaikan atau koreksi dilakukan. Perbaikan ini dapat berupa perubahan prosedur, peningkatan pelatihan, atau perubahan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu perawatan ke depan.

5. Umpan Balik (*Feedback*)

Tahap terakhir dalam pengendalian mutu adalah memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat, baik kepada perawat maupun kepada manajemen. Umpan balik ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian hasil dan area yang perlu ditingkatkan.

Pada sistem pengendalian mutu dalam keperawatan sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien, mengurangi risiko kesalahan medis, serta menciptakan suasana kerja yang lebih terorganisir dan efektif (Nursalam, 2013).

C. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan keperawatan mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan tidak hanya efektif tetapi juga memenuhi harapan pasien. Beberapa dimensi utama mutu pelayanan keperawatan adalah:

1. Efektivitas (Donabedian, 1988)

Efektivitas mengacu pada sejauh mana asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas asuhan keperawatan dapat diukur melalui keberhasilan intervensi dalam memperbaiki kondisi kesehatan pasien, seperti pengurangan gejala, perbaikan fungsi tubuh, atau peningkatan kualitas hidup.

2. Efisiensi (Donabedian, 1988)

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang optimal untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Dalam pelayanan keperawatan, efisiensi dapat dicapai melalui pengelolaan waktu, pengurangan prosedur yang tidak perlu, dan penerapan teknologi untuk mendukung kerja perawat.

3. Keamanan (*Safety*) (Effendy, 2018)

Dimensi keamanan ini memastikan bahwa asuhan keperawatan dilakukan tanpa membahayakan pasien. Kesalahan medis, infeksi nosokomial, dan cedera akibat prosedur perawatan adalah contoh risiko yang harus diminimalkan dalam

praktik keperawatan. Budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perawatan yang aman.

4. Keterjangkauan (*Accessibility*) (Effendy, 2018)

Keterjangkauan berkaitan dengan kemampuan pasien untuk mengakses layanan keperawatan tanpa hambatan geografis, finansial, atau sosial. Dimensi ini menekankan pentingnya kehadiran perawat yang cukup, distribusi layanan yang merata, dan penyesuaian dengan kebutuhan pasien di berbagai lokasi.

5. Kesenambungan (*Continuity*) (Potter & Perry, 2020)

Kesenambungan asuhan keperawatan mengacu pada koordinasi layanan yang berkelanjutan, baik antarperawat maupun antarprofesi kesehatan. Hal ini mencakup pelaporan yang baik, perencanaan pulang pasien (*discharge planning*), dan tindak lanjut untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang konsisten.

6. Kepuasan Pasien (Sutcliffe, Paine, & Pronovost, 2017)

Dimensi ini mencerminkan pengalaman subjektif pasien terhadap asuhan keperawatan yang diterima. Faktor seperti komunikasi yang baik, perhatian perawat terhadap kebutuhan pasien, dan sikap yang ramah memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien juga menjadi indikator penting dalam evaluasi mutu pelayanan.

7. Ketersesuaian (*Appropriateness*) (Sutcliffe, Paine, & Pronovost, 2017)

Ketersesuaian mengacu pada sejauh mana tindakan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individual pasien, kondisi medis, dan preferensi mereka. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pasien (*patient-centered care*).

A. Instrumen dan Metode Pengendalian Mutu Keperawatan

Salah satu aspek penting dalam pengendalian mutu adalah penggunaan instrumen dan metode yang tepat untuk mengukur, memantau, dan memperbaiki kualitas layanan keperawatan. Instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa standar mutu yang ditetapkan dapat dipenuhi secara konsisten (Nursalam, 2013). Beberapa instrumen yang biasa digunakan dalam pengendalian mutu keperawatan antara lain:

1. Audit Keperawatan

Audit keperawatan adalah suatu metode untuk memeriksa dan menilai apakah praktik keperawatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara tindakan keperawatan yang dilakukan dengan pedoman yang ada. Audit ini dapat

bersifat retrospektif (menilai tindakan yang sudah dilakukan) atau prospektif (melakukan evaluasi berdasarkan data yang ada) (Aiken & Sloane, 2020).

2. Daftar Periksa (*Checklist*)

Daftar periksa (*checklist*) digunakan untuk memastikan bahwa setiap prosedur keperawatan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Checklist ini mencakup hal-hal penting yang harus dilakukan oleh perawat, seperti memeriksa identitas pasien, memberikan terapi sesuai prosedur, dan melakukan evaluasi terhadap respon pasien (Aiken & Sloane, 2020).

3. Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*)

KPI adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja layanan keperawatan berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti kepuasan pasien, tingkat infeksi, angka kejadian efek samping, dan tingkat kesalahan medis. KPI memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana layanan yang diberikan mencapai standar yang ditetapkan (Aiken & Sloane, 2020).

4. Survei Kepuasan Pasien

Instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan adalah survei kepuasan pasien. Survei ini mengumpulkan umpan balik pasien mengenai berbagai aspek perawatan yang mereka terima, termasuk komunikasi dengan perawat, keterampilan teknis, dan perhatian terhadap kebutuhan pasien (Sukartini & Sudiardja, 2019).

5. Sistem Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (*Incident Reporting*)

Pelaporan kejadian tidak diinginkan atau kejadian yang tidak diinginkan (*adverse events*) sangat penting dalam pengendalian mutu. Dengan menggunakan sistem pelaporan yang terstruktur, rumah sakit dapat mengidentifikasi dan menganalisis kejadian yang tidak diinginkan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan (Sukartini & Sudiardja, 2019).

Metode pengendalian mutu keperawatan digunakan untuk memastikan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan:

1. Metode *Total Quality Management* (TQM) (Deming, 1986)

Metode ini melibatkan partisipasi semua anggota organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kualitas perawatan. Dalam konteks keperawatan, TQM bertujuan untuk menciptakan budaya kualitas yang berfokus pada kepuasan pasien dan perbaikan berkelanjutan.

2. Metode *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) (Glickman, 2007)

Metode PDCA adalah siklus yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses pengendalian mutu. Metode ini digunakan untuk merencanakan standar perawatan, melaksanakan prosedur, memeriksa hasil yang diperoleh, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Siklus ini dilakukan berulang kali untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

3. Metode Six Sigma (Nursalam, 2013)

Six Sigma adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengurangi variabilitas dalam proses pelayanan keperawatan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi dengan mengurangi jumlah kesalahan atau cacat dalam pelayanan. Metode ini berfokus pada pengukuran dan analisis data untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah dalam pelayanan keperawatan.

4. Metode Benchmarking (Dewi & Santoso, 2016)

Benchmarking adalah proses perbandingan antara kinerja atau kualitas pelayanan keperawatan yang ada dengan praktik terbaik yang ada di industri atau institusi lain. Dengan menggunakan benchmarking, rumah sakit atau fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menerapkan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan.

5. Metode *Root Cause Analysis* (RCA) (Dewi & Santoso, 2016)

Metode ini digunakan untuk menganalisis akar penyebab dari masalah atau kesalahan yang terjadi dalam praktik keperawatan. Setelah masalah diidentifikasi, RCA membantu mengungkap penyebab mendasar, yang kemudian digunakan untuk merancang solusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

6. Metode *Clinical Pathways* (Protokol Klinis) (Greenhalgh & Stones, 2017)

Instrumen ini berbentuk protokol yang digunakan untuk memberikan panduan dalam memberikan perawatan kepada pasien dengan kondisi tertentu. Metode ini memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dengan bukti terbaik yang tersedia dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Penggunaan instrumen dan metode pengendalian mutu sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan perawat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, aman bagi pasien, dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

B. Prinsip Manajemen Mutu Terpadu

Menurut Deming (1986), manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management* atau TQM) adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dalam seluruh aspek organisasi, dengan melibatkan semua

anggota organisasi dan berfokus pada kebutuhan pelanggan. Menurut Oakland (2014), Prinsip utama manajemen mutu terpadu meliputi

1. *Customer Focus* (Fokus Pada Pelanggan)

Fokus pada pelanggan menjadi pilar utama dalam TQM. Semua kegiatan dan proses organisasi diarahkan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan, baik pelanggan internal (karyawan) maupun eksternal (konsumen). Dengan memahami kebutuhan pelanggan, organisasi dapat merancang proses yang lebih efisien dan efektif (Darmawan, 2020).

2. *Continuous Improvement* (Perbaikan Berkelanjutan)

Prinsip perbaikan berkelanjutan menekankan pentingnya inovasi dan pembelajaran dari setiap kegagalan untuk menghasilkan produk dan layanan yang semakin baik (Juran & Gryna, 1993).

3. *Total Involvement* (Keterlibatan Penuh)

Keterlibatan penuh dari semua individu dalam organisasi juga menjadi prinsip penting dalam TQM. Setiap karyawan, dari level manajemen hingga staf operasional, memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Pendekatan ini mendorong kerja sama tim dan komunikasi yang terbuka (Goetsch & Davis, 2021).

4. *Process-Centered Approach* (Pendekatan Berorientasi Pada Proses)

Pendekatan berorientasi proses memastikan bahwa setiap langkah dalam sistem operasi dikelola dengan baik untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sering dicapai melalui pemetaan dan analisis proses kerja menggunakan alat seperti diagram alur dan peta proses (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2022).

5. *Data-Driven Decision-Making* (Pengambilan Keputusan Berbasis Data)

Prinsip pengambilan keputusan berbasis data menjadi penggerak utama dalam implementasi TQM. Dengan menggunakan data yang valid dan akurat, organisasi dapat mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai. Misalnya, indikator mutu seperti tingkat kepuasan pelanggan, waktu tunggu pelayanan, atau persentase produk cacat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan TQM (Hidayat, 2019).

Selain itu, kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dari manajemen puncak merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi prinsip-prinsip TQM (Setiawan, 2021). Pemimpin bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, menginspirasi karyawan untuk berkontribusi, dan memastikan bahwa prinsip TQM diintegrasikan dalam strategi organisasi. Manajemen mutu terpadu telah diterapkan secara luas dalam berbagai sektor,

seperti industri manufaktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa (Notoatmodjo, 2021).

C. Indikator Mutu Keperawatan

Indikator mutu keperawatan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif pada kesehatan pasien. Indikator mutu keperawatan dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan model Donabedian (1988), yaitu struktur, proses, dan hasil (*outcome*).

1. Indikator Struktur

Meliputi elemen-elemen seperti jumlah dan kualifikasi tenaga keperawatan, rasio perawat terhadap pasien, fasilitas dan peralatan yang tersedia, serta keberadaan panduan atau prosedur operasional standar (POS). Indikator ini menilai kesiapan dan kapabilitas sumber yang mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan.

2. Indikator Proses

Berfokus pada bagaimana pelayanan keperawatan diberikan. Indikator ini mencakup kepatuhan perawat terhadap standar prosedur, ketepatan waktu pemberian obat, dokumentasi asuhan keperawatan, dan komunikasi dengan pasien serta tim medis lainnya. Penilaian indikator proses bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan protokol yang berlaku.

3. Indikator Hasil (*Outcome*)

Mengukur dampak langsung dari asuhan keperawatan terhadap kondisi pasien. Contoh indikator hasil meliputi tingkat kepuasan pasien, penurunan tingkat nyeri, waktu penyembuhan luka, tingkat kejadian infeksi nosokomial, serta angka kejadian jatuh pasien di fasilitas kesehatan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas intervensi keperawatan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam penerapan indikator mutu keperawatan, pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Marquis & Huston, 2021). Misalnya, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan dapat diukur melalui survei atau wawancara, sementara kejadian insiden keselamatan pasien dapat dianalisis melalui sistem pelaporan insiden. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi tim manajemen keperawatan untuk merumuskan strategi peningkatan mutu. Menurut Ellis dan Hartley (Ellis & Hartley, 2018), pentingnya indikator mutu keperawatan juga terletak pada perannya dalam

mendukung keselamatan pasien (*patient safety*). Dengan memantau indikator seperti kejadian jatuh atau kesalahan pemberian obat, fasilitas kesehatan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko. Selain itu, indikator mutu keperawatan membantu memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat menyeluruh, manusiawi, dan berbasis bukti.

D. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Apa tujuan utama dari penjaminan mutu pelayanan kesehatan?
 - A. Meningkatkan efisiensi biaya pelayanan
 - B. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis
 - C. Memastikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
 - D. Mengurangi jumlah pasien yang dilayani
 - E. Menghilangkan peran multidisiplin dalam perawatan
2. Dimensi mutu pelayanan yang menekankan pada keamanan pasien adalah...
 - A. Efisiensi
 - B. Efektivitas
 - C. Ketersesuaia
 - D. Keamanan
 - E. Kepuasan pasien
3. Pendekatan multidisiplin dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan bertujuan untuk...
 - A. Membatasi intervensi tenaga kesehatan lain
 - B. Mengoptimalkan pelayanan terintegrasi
 - C. Meningkatkan fokus pada satu profesi tertentu
 - D. Mengurangi kolaborasi antarprofesi
 - E. Mempermudah prosedur administrative
4. Apa langkah pertama dalam pendekatan PDCA?
 - A. Check
 - B. Do
 - C. Act
 - D. Plan
 - E. Evaluate
5. Indikator mutu keperawatan yang menilai hasil langsung dari asuhan keperawatan disebut...
 - A. Indikator struktur
 - B. Indikator proses
 - C. Indikator hasil (outcome)

- D. Indikator efisiensi
 - E. Indikator keamanan
6. Apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis pasien?
 - A. Fokus pada kebutuhan organisasi
 - B. Menyesuaikan asuhan dengan kebutuhan pasien
 - C. Memberikan pelayanan secara seragam
 - D. Mengurangi interaksi langsung dengan pasien
 - E. Mengutamakan teknologi dalam pelayanan
 7. Apa prinsip utama dari TQM yang menekankan pada inovasi dan pembelajaran?
 - A. Fokus pada pelanggan
 - B. Keterlibatan penuh
 - C. Perbaikan berkelanjutan
 - D. Pengambilan keputusan berbasis data
 - E. Pendekatan proses
 8. Salah satu alat manajemen mutu yang digunakan untuk menganalisis proses kerja adalah...
 - A. Sistem pelaporan insiden
 - B. Survei kepuasan pelanggan
 - C. Diagram alir
 - D. Supervisi langsung
 - E. Indikator keamanan
 9. Apa peran utama indikator proses dalam mutu keperawatan?
 - A. Menilai dampak langsung asuhan
 - B. Mengevaluasi kepatuhan terhadap standar prosedur
 - C. Menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
 - D. Memastikan aksesibilitas pasien
 - E. Memantau penggunaan sumber daya
 10. Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) berperan dalam...
 - A. a. Mengurangi kebutuhan teknologi
 - B. b. Meningkatkan efisiensi kerja dan pengurangan kesalahan medis
 - C. c. Membatasi keterlibatan multidisiplin
 - D. d. Menghapuskan budaya keselamatan pasien
 - E. e. Mengurangi aksesibilitas layanan
 11. Dimensi mutu pelayanan yang berkaitan dengan kemampuan pasien mengakses layanan disebut...
 - A. Efisiensi
 - B. Keterjangkauan
 - C. Keamanan

- D. Kesiambungan
 - E. Kepuasan pasien
12. Metode PDCA digunakan untuk...
- A. a. Merencanakan dan mendokumentasikan pasien
 - B. b. Mengelola waktu dan sumber daya
 - C. c. Melakukan perbaikan mutu secara terus-menerus
 - D. d. Memisahkan tim medis berdasarkan tugas
 - E. e. Mengurangi indikator mutu
13. Dimensi mutu yang menekankan pada komunikasi antarprofesi untuk perawatan konsisten adalah...
- A. Efisiensi
 - B. Efektivitas
 - C. Kesiambungan
 - D. Keteresuaian
 - E. Keamanan
14. Budaya keselamatan pasien bertujuan untuk...
- A. Mengurangi kebutuhan pelatihan tenaga medis
 - B. Meningkatkan risiko prosedur
 - C. Menghindari kesalahan medis dan cedera
 - D. Mengurangi peran pasien dalam pelayanan
 - E. Membatasi asuhan berbasis bukti
15. Apa contoh dari indikator struktur dalam mutu keperawatan?
- A. Kepuasan pasien
 - B. Dokumentasi asuhan
 - C. Rasio perawat terhadap pasien
 - D. Penurunan gejala pasien
 - E. Ketepatan pemberian obat

Essay

1. Jelaskan tujuan utama penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan bagaimana pendekatan multidisiplin mendukung pencapaiannya.
2. Deskripsikan langkah-langkah dalam pendekatan PDCA dan pentingnya evaluasi dalam siklus ini.
3. Sebutkan dan jelaskan tiga dimensi mutu pelayanan keperawatan beserta contohnya.
4. Apa peran indikator mutu dalam evaluasi asuhan keperawatan, dan berikan contoh indikator pada masing-masing kategori (struktur, proses, hasil)?

5. Bagaimana teknologi informasi, seperti SIMRS, mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan?

E. Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. B
4. D
5. C
6. B
7. C
8. C
9. B
10. B
11. B
12. C
13. C
14. C
15. C

F. Rangkuman Materi

Pengendalian mutu dalam pelayanan kesehatan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mutu pelayanan kesehatan mencakup aspek aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepuasan pasien. Dalam asuhan keperawatan, penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar praktik berbasis bukti, pedoman klinis, dan kode etik profesi, sehingga menghasilkan pelayanan yang aman, efektif, dan manusiawi. Dimensi mutu pelayanan keperawatan meliputi efektivitas, efisiensi, keamanan, keterjangkauan, kesinambungan, kepuasan pasien, dan ketersesuaian dengan kebutuhan individu pasien. Implementasi manajemen mutu terpadu (TQM) juga menjadi prinsip penting dalam meningkatkan kualitas, dengan fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan semua anggota organisasi, pendekatan berbasis proses, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Indikator mutu keperawatan dibagi menjadi struktur, proses, dan hasil (outcome), yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), turut mendukung pengendalian mutu melalui pencatatan data yang akurat,

pengelolaan obat, dan pemantauan mutu secara real-time. Selain itu, budaya keselamatan pasien harus menjadi bagian integral dari organisasi, memastikan kolaborasi antarprofesi dalam menciptakan layanan kesehatan yang terintegrasi, aman, dan berkualitas tinggi.

G. Glosarium

Asuhan Keperawatan: Serangkaian tindakan atau intervensi oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien.

Budaya Keselamatan Pasien: Pendekatan organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik perawatan yang aman.

Efektivitas: Tingkat keberhasilan layanan kesehatan dalam mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan praktik berbasis bukti.

Efisiensi: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.

Indikator Mutu Keperawatan: Alat ukur untuk menilai kualitas asuhan keperawatan, meliputi indikator struktur, proses, dan hasil.

Infeksi Nosokomial: Infeksi yang diperoleh pasien selama berada di fasilitas kesehatan.

Keselamatan Pasien: Dimensi layanan yang memastikan asuhan diberikan tanpa membahayakan pasien.

Keterjangkauan: Kemampuan pasien untuk mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan geografis, finansial, atau sosial.

Kesinambungan: Koordinasi layanan secara berkelanjutan antara profesi kesehatan untuk memastikan perawatan konsisten.

Kepuasan Pasien: Indikator pengalaman subjektif pasien terhadap kualitas layanan yang diterima.

Manajemen Mutu Terpadu (TQM): Pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus dalam organisasi, melibatkan semua anggota dan fokus pada pelanggan.

Penjaminan Mutu: Upaya sistematis untuk memastikan bahwa layanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan melalui pengukuran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Plan-Do-Check-Act (PDCA): Pendekatan manajemen mutu untuk perbaikan berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan lanjutan.

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Teknologi untuk pencatatan data pasien secara elektronik dan pengelolaan layanan kesehatan secara efisien.

H. Daftar Pustaka

- Azwar, A. (2019). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Burns, N., & Grove, S. K. (2020). *Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice*. St. Louis: Elsevier.
- Darmawan, D. (2020). Implementasi Total Quality Management dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 212-224.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge: MIT Press.
- Donabedian, A. (1988). The Quality of Care: How Can It Be Assessed? *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743–1748.
- Effendy, N. (2018). *Asuhan Keperawatan: Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Ellis, J. R., & Hartley, C. L. (2018). *Nursing in Today's World: Trends, Issues, and Management*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Glickman, S. W. (2007). Pay-for-Performance, Quality of Care, and Outcomes in Acute Myocardial Infarction. *Journal of the American Medical Association*, 297(21), 2373–2380.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2021). *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality*. Boston: Pearson.
- Hidayat, T. (2019). Manajemen Mutu Terpadu di Rumah Sakit: Studi Kasus pada Peningkatan Keselamatan Pasien. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 115-124.
- JCI. (2021). *Accreditation Standards for Hospitals*. Oak Brook, Illinois: Joint Commission Resources.
- Juran, J. M., & Gryna, F. M. (1993). *Quality Planning and Analysis: From Product Development through Use*. New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). *To Err is Human: Building a Safer Health System*. Washington, DC: National Academy Press.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2022). *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Upper Saddle River: Pearson.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application*. Philadelphia: Wolters Kluwer.

- Notoatmodjo, S. (2021). *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oakland, J. S. (2014). *Total Quality Management and Operational Excellence: Text with Cases*. London: Routledge.
- Potter, P., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. St. Louis: Elsevier.
- Setiawan, I. (2021). Peran Kepemimpinan dalam Total Quality Management di Sektor Jasa. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(1), 32-45.
- Sutcliffe, K. M., Paine, L., & Pronovost, P. J. (2017). Re-examining High Reliability: Achieving Resilience in Health Care Systems. *Health Services Research*, 52(5), 1793–1816.

BAB 6

KONFERENSI DAN TIMBANG TERIMA SESUAI KONSEP MANAJEMEN

Pendahuluan:

Dalam praktik keperawatan, proses konferensi dan timbang terima pasien merupakan langkah yang sangat penting. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kelancaran alur informasi dan koordinasi di antara tenaga keperawatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perawatan.

Konferensi bertujuan untuk membahas kondisi pasien, merumuskan rencana perawatan, dan mengevaluasi perkembangan pengobatan. Pada kesempatan ini, setiap anggota tim diharapkan memahami peran masing-masing, berbagi informasi terkini mengenai pasien, serta menentukan tindakan atau prosedur yang diperlukan untuk mencapai hasil perawatan yang optimal. Biasanya, konferensi ini dilaksanakan secara teratur, baik itu setiap hari, mingguan, atau sesuai dengan kebutuhan pasien.

Di sisi lain, proses timbang terima memberikan gambaran awal mengenai kondisi pasien, termasuk tujuan dari pemeriksaan atau pengobatan yang akan dilakukan, serta informasi dasar yang diperlukan oleh tenaga keperawatan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kedua proses ini, diharapkan perawatan yang diberikan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Bab ini mengulas mengenai konferensi dan timbang terima dalam konteks Manajemen. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang konsep serta pelaksanaan konferensi dan timbang terima. Buku ini ditujukan khusus untuk mahasiswa diploma tiga keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah konferensi terdiri dari definisi, tujuan, pedoman pelaksanaan, *pre* dan *post conference*, tujuan *pre conference*, tujuan *post conference*, tuntutan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *pre* dan *post conference*. Dan juga membahas tentang timbang terima yang terdiri dari definisi, tujuan, manfaat timbang terima yang efektif, prinsip timbang terima, langkah-langkah pelaksanaan timbang terima, faktor-faktor yang mempengaruhi timbang terima, jenis timbang terima, metode timbang terima : SBAR, proses timbang terima di samping tempat tidur pasien, lima tips teknik timbang terima dan dokumentasi timbang terima. Struktur Bab

ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab.

Tujuan Intruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran, para peserta didik diharapkan dapat :

- Mampu memahami konsep dan pelaksanaan Konferensi
- Mampu memahami konsep dan pelaksanaan timbang terima

Capaian Pembelajaran:

Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan:

- Mampu menjelaskan definisi Konferensi
- Mampu menjelaskan tujuan Konferensi
- Mampu menjelaskan pedoman pelaksanaan Konferensi
- Mampu menjelaskan *Pre Conference* dan *Post Conference*
- Mampu menjelaskan Tujuan *Pre Conference*
- Mampu menjelaskan Tujuan *Post Conference*
- Mampu menjelaskan persyaratan dalam pelaksanaan *Pre* dan *Post Conference*
- Mampu menjelaskan definisi timbang terima
- Mampu menjelaskan tujuan timbang terima
- Mampu menjelaskan manfaat timbang terima yang efektif
- Mampu menjelaskan prinsip timbang terima
- Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan timbang terima
- Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi timbang terima
- Mampu menjelaskan jenis timbang terima
- Mampu menjelaskan metode timbang terima : SBAR
- Mampu menjelaskan proses timbang terima di samping tempat tidur pasien
- Mampu menjelaskan lima tips teknik timbang terima
- Mampu melakukan dokumentasi timbang terima

Uraian Materi

A. Defisini Konferensi

Menurut Swanburg (2012) Konferensi adalah bentuk diskusi kelompok tentang berbagai aspek praktik klinis pasien. Konferensi adalah diskusi kelompok mengenai berbagai elemen dari aktivitas klinis pasien sebelum dan setelah tindakan yang dilakukan pada individu pasien tersebut. (Syah Putra, 2016).

B. Tujuan Konferensi (Suarli, 2012). (Silvia Nur, 2024)

1. Merencanakan perawatan pasien secara individu. Konferensi ini diharapkan setiap staf memberikan masukan dalam pembahasan asuhan pasien secara individu dan komprehensif.
2. Mengoordinasikan semua layanan yang sesuai. Kelompok diharapkan memiliki pemahaman terperinci tentang layanan terhadap pasien dapat dipergunakan dengan optimal.
3. Meningkatkan semangat bekerja sama.
4. Dalam proses perawatan pasien, tim dapat berkolaborasi, meningkatkan pengetahuan, serta terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan.
5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman staf perawat pada saat konferensi. Di mana segala sesuatu tentang klien didiskusikan bersama-sama dan juga terhadap peran masing-masing staf terlihat jelas dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dan kerahasiaan pasien juga tetap diperhatikan.
6. Mengkritisi analisis masalah
7. Memberikan rincian alternatif dalam pemecahan masalah untuk memberikan gambaran tentang situasi di berbagai bidang.

C. Pedoman Pelaksanaan Konferensi

1. Jelaskan tujuan Konferensi
2. Jelas terlihat proses dan dinamika kelompok pada saat diskusi
3. Topik yang penting harus disiapkan terlebih dahulu oleh pemimpin secara periodik
4. Di saat pertemuan, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan perhatian tetap terarah, tidak mengambil alih percakapan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
5. Durasi yang dialokasikan adalah antara 15 hingga 30 menit.
6. Suasana diskusi yang kondusif sangat mendukung kelompok, bertanggung jawab dan siap menerima pendapat yang berbeda.

7. Pada saat diskusi ruang diatur dengan baik, sehingga dapat tatap muka pada saat diskusi
8. Staf yang sebelumnya akan menyampaikan hasil penilaian terkait kemajuan dan permasalahan pasien
9. Diskusi dan arahan tentang masalah terkait dengan keperawatan pasien dilakukan oleh perawat primer
10. Ingatkan tentang Standar Prosedur Operasional
11. Ingatkan tentang pentingnya komunikasi, disiplin, ketelitian, kejujuran, dan perkembangan dari setiap staf.
12. Memberikan bantuan kepada staf yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani.
13. Pimpinan konferensi merangkum hasil diskusi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan..

D. Pre dan Post Conference

Pre Conference adalah sesi dialog antara tim dan perawat pelaksana yang dilakukan setelah proses serah terima selesai. Dalam pertemuan ini, rencana kegiatan untuk shift yang sedang berlangsung dibahas, dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab. *Post Conference* adalah komunikasi antara perawat utama dan perawat pelaksana yang membahas hasil kegiatan yang terjadi selama shift, sebelum melanjutkan ke shift berikutnya. Dalam Post Conference, terdapat laporan terkait hasil perawatan yang diberikan kepada setiap pasien serta informasi penting yang harus disampaikan untuk tindak lanjut operan.

E. Tujuan Pre Conference

1. Membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi pasien, merancang perawatan yang sesuai, dan menyusun evaluasi hasilnya.
2. Mempersiapkan aspek-aspek yang mungkin dihadapi di lapangan.
3. Menyediakan kesempatan untuk mendiskusikan kondisi pasien.

F. Tujuan Post Conference (Nursalam, 2014)

Hal ini bertujuan untuk membahas solusi atas masalah yang ada dan membandingkan isu yang dihadapi. Oleh karena itu, *Pre Conference* yang dilaksanakan meliputi:

1. Penentuan waktu untuk *Post Conference*.
2. Pembahasan mengenai solusi masalah klien.
3. Diskusi mengenai kesenjangan yang ditemukan antara rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan.

4. Pengaturan dan penetapan rencana tindakan selanjutnya.

G. Persyaratan dalam pelaksanaan *Pre* dan *Post Conference* yaitu :

1. Tujuan yang telah ditentukan selama konferensi harus dicek kembali sebelumnya.
2. Dialog yang sedang terjadi hendaknya mencerminkan nilai-nilai kelompok yang selalu berubah.
3. Instruktur klinis memiliki fungsi yang krusial dalam menjaga kelangsungan diskusi dengan tetap terfokus pada topik, tanpa mengambil alih, sambil memberikan umpan balik yang tepat.
4. Instruktur klinis harus menyoroti hal-hal penting sepanjang berlangsungnya diskusi.
5. Atmosfer diskusi sebaiknya mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota, sehingga setiap orang mau memberikan tanggapan dan menerima pandangan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama.
6. Pastikan anggota kelompok dapat berinteraksi secara langsung.
7. Di akhir konferensi, ringkasan dan kesimpulan sebaiknya disampaikan oleh instruktur klinis atau siswa, dengan merujuk pada tujuan pembelajaran dan penerapannya dalam berbagai situasi dan kondisi. (Swansburg, 2012)

H. Definisi Timbang Terima

Timbang terima, yang sering dikenal sebagai operan, adalah sebuah metode untuk mentransfer dan menerima data mengenai status pasien.

Timbang terima menjadi elemen penting dalam pengalihan informasi selama transisi perawatan berkelanjutan. Proses ini meliputi pertanyaan, penjelasan, dan verifikasi terkait keadaan pasien, termasuk penegasan tanggung jawab dan otoritas perawat dari sebelumnya kepada perawat yang akan melanjutkan perawatan.

Timbang terima adalah teknik kunci dalam mengkomunikasikan dan menerima rincian mengenai kondisi pasien. Prosedur ini perlu dilakukan dengan sebaik mungkin; perawat diharuskan memberikan penjelasan yang ringkas, jelas, dan menyeluruh mengenai tindakan yang telah diambil, kerjasama yang masih sedang berlangsung, serta perkembangan terbaru pasien. Keakuratan informasi yang disampaikan sangat penting agar kelanjutan asuhan keperawatan dapat terlaksana dengan optimal.

I. Tujuan Timbang Terima

1. Mengidentifikasi masalah keperawatan pasien

2. Untuk memastikan bahwa informasi yang relevan, akurat dan terkini mengenai perawatan pasien ditransfer ke orang yang tepat, tindakan diambil (bila diperlukan) dan kesinambungan perawatan pasien tetap terjaga.
3. Membantu merencanakan asuhan keperawatan secara kooperatif dengan anggota tim lainnya
4. Membantu berkomunikasi dalam memberikan ide, kreatifitas, informasi spesifik yang faktual tentang asuhan keperawatan terkait
5. Memanfaatkan informasi ilmiah dalam pelaksanaan asuhan keperawatan
6. membantu melaporkan, menafsirkan, menyalurkan dan melaksanakan masalah rumah sakit atau pelayanan kesehatan.
7. Mengajarkan apa yang diperlukan untuk membantu anggota tim memenuhi peran mereka

J. Manfaat Timbang Terima (NHS, 2008)

1. Meminimalkan penundaan dalam perawatan pasien
2. Mengurangi biaya perawatan
3. Pengurangan kelalaian perawatan dan kesalahan medis
4. Mengurangi lama rawat di rumah sakit
5. Kejelasan persyaratan perawatan pasien
6. Peningkatan keselamatan pasien
7. Peningkatan perawatan dan hasil pasien

K. Prinsip Timbang Terima

1. Efisien
2. Informasi yaitu :
 - a. Relevan
 - b. Ringkas
 - c. Tidak terulang
 - d. Terstandarisasi
 - e. Di satu tempat
 - f. Tidak ada gangguan
3. Dalam waktu yang ditentukan – rata-rata 15 - 20 menit
4. Dimulai dan diakhiri tepat waktu
5. Mengkomunikasikan informasi yang benar
6. Fokus pada tujuan pasien
7. Mengklarifikasi perubahan signifikan untuk pasien dengan mudah
8. Membantu melakukan proses lainnya di bangsal lebih efisien
9. Perencanaan penerimaan dan pemulangan pasien

10. Pemantauan keterisian tempat tidur
11. Perencanaan Pengobatan multidisiplin
12. Berkomunikasi secara obyektif, tepat dan ringkas dengan tenaga kesehatan lainnya
13. Memahami dan menggunakan terminologi medis/keperawatan
14. Menafsirkan bagan dan dokumen lainnya
15. Memahami prosedur klinis dan
16. Tuliskan hasil pengamatan pasien

L. Langkah-langkah pelaksanaan timbang terima (Nursalam, 2014)

1. Peserta diskusi semua sudah dalam keadaan siap untuk bertugas.
2. Dinas yang akan melakukan serah terima harus mempersiapkan semua yang diperlukan.
3. Perawat Primer wajib menyampaikan informasi kepada yang bertanggung jawab di dinas, yang meliputi:
 - a. Keadaan umum pasien
 - b. Tindakan lanjutan yang perlu diambil oleh dinas penerima
 - c. Rencana kegiatan dari dinas yang menerima
 - d. Proses penyerahan harus dijelaskan dengan jelas dan tanpa terburu-buru
 - e. Perawat Primer dan anggota dari kedua dinas harus secara bersama-sama mengevaluasi kondisi pasien secara langsung.

M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbang Terima

1. Supervisi
2. Pendidikan
3. Komunikasi
4. Pengetahuan
5. Motivasi
6. Sikap

N. Jenis Timbang Terima

1. Timbang terima pasien saat pergantian jadwal:

Proses Timbang terima pasien saat terjadi pergantian shift dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut meliputi komunikasi tatap muka, pemberian catatan keperawatan baik yang ditulis tangan maupun yang menggunakan media digital. Proses ini dapat dilakukan di samping tempat tidur pasien, melalui telepon, menggunakan rekaman, dan masih banyak lagi.

2. Timbang terima pasien di antara ruang perawatan:

Selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit, mereka seringkali berpindah antar ruang perawatan. Proses transfer ini semakin menjadi hal yang umum terjadi.

3. Timbang terima pasien antara unit perawatan dan unit diagnostik:

Selama masa perawatan inap, pasien seringkali dikirim untuk menjalani pemeriksaan diagnostik. Pengiriman dari unit perawatan menuju unit pemeriksaan diagnostik, seperti laboratorium, radiologi, kateterisasi jantung, EEG, EMG, dan lainnya, telah menjadi area yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

4. Timbang terima pasien antar fasilitas kesehatan:

Proses pemindahan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya biasanya dilakukan dalam konteks pengaturan layanan yang berbeda. Hal ini sering terjadi antar rumah sakit ketika pasien memerlukan tingkat perawatan yang lebih tepat. Pemindahan pasien dapat mencakup beragam jenis fasilitas, termasuk antar rumah sakit, pusat rehabilitasi, layanan kesehatan di rumah, serta organisasi pelayanan kesehatan lainnya. (Ardoin & Broussard, 2011)

O. Metode Timbang terima : SBAR (Buechel Cat, 2024)

Dalam pelaksanaan handover SBAR (*Situation Background Assessment Recommendation*) adalah alat komunikasi yang efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien. Melalui proses pemantauan dan evaluasi keselamatan, SBAR terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan pasien di rumah sakit.

1. *Situation:*

Mencakup rincian pasien, alasan singkat mengapa Anda menyerahkan pasien, dan memastikan bahwa Anda menyerahkan kepada orang yang tepat, dan bahwa mereka tahu siapa Anda

2. *Background:*

Informasi apa pun tentang penerimaan pasien dan riwayat kesehatan masa lalu hingga saat ini yang relevan

3. *Assessment:*

Apa yang Anda temukan dalam penilaian? Intervensi apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Menurut Anda apa yang terjadi pada pasien tersebut?

4. *Recommendation:*

Apa yang Anda ingin kolega Anda lakukan untuk pasien pada shiftnya

P. Lima tips teknik timbang terima

1. Terorganisir

Cobalah untuk mengikuti urutan yang terorganisir ketika Timbang terima: rincian pasien, keluhan yang disampaikan, riwayat signifikan, pengobatan dan rencana perawatan. Sertakan pengamatan klinis, hasil patologi, prosedur, dll. Jangan lupa untuk menyoroti alergi, riwayat pasien yang relevan, dan kondisi medis lainnya.

2. Tetap fokus

Tetap relevan. Jangan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi pada pasien sepanjang giliran kerja; terkadang hal ini membutuhkan kepercayaan diri dan pengalaman untuk mengetahui apa yang penting untuk disampaikan. Tegaskan kembali status dan rencana perawatan pasien saat ini dan yang akan dilanjutkan.

3. Berkomunikasi dengan jelas

Singkat dan bicaralah dengan jelas. Tekankan kebutuhan atau kekhawatiran utama, seperti apakah observasi berikutnya atau antibiotik IV akan segera diberikan. Gunakan terminologi medis dan keperawatan yang relevan. Hindari singkatan atau ambigu. Jika Anda akan melakukan Timbang terima kepada staf lulusan baru atau staf junior, jelaskan anomali apa pun pada perawatan atau pengobatan pasien yang mungkin tidak mereka kenal. Periksa apakah kolega Anda mendengarkan dan memperhatikan – jika perhatiannya terganggu, ajukan pertanyaan.

4. Berpusat pada pasien

Bukan hanya informasi klinis saja yang penting, bagaimana suasana hati pasien Anda? Apakah mereka datar, tertekan, cemas, prihatin, menangis? Sampaikan kekhawatiran atau kebutuhan spesifik pasien Anda.

5. Berikan waktu

Gunakan waktu Timbang terima dengan bijak. Meskipun manajemen waktu yang efektif mencakup Timbang terima klinis, semua informasi penting harus disampaikan. Usahakan untuk tidak terburu-buru atau berbicara terlalu cepat, khususnya untuk rekaman laporan Timbang terima. Bersikaplah terbuka dan dorong pertanyaan jika itu adalah penyerahan lisan. Jika rekan kerja tampak tidak yakin dengan apa yang Anda katakan, ulangi atau jelaskan apa yang Anda katakan.

Timbang terima yang tidak efektif dapat menyebabkan kejadian buruk, keterlambatan perawatan dan komplikasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Timbang terima yang efektif dapat menghasilkan layanan yang tepat

waktu, berkualitas, dan hasil akhir yang baik bagi pasien. (Australian Nursing and Midwifery Journal, (2020)

Q. Proses timbang terima di samping tempat tidur pasine (Chaboyer, 2008)

1. Persiapan

- a. Alokasikan pasien dengan baik.
- b. Perbarui lembar serah terima.
- c. Informasikan kepada pasien.
- d. Minta pengunjung selain keluarga untuk meninggalkan ruangan.

2. Pendahuluan

- a. Pemimpin membangun hubungan yang baik dengan pasien.
- b. Pemimpin memperkenalkan staf kepada pasien.

3. Pertukaran Informasi

- a. Sampaikan kondisi klinis pasien.
- b. Diskusikan tes dan prosedur yang akan dilakukan.
- c. Bicarakan tentang bantuan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (ADL).
- d. Rencanakan pemulangan pasien.
- e. Tanya jawab dengan staf terkait informasi yang perlu dicatat.

4. Keterlibatan Pasien

- a. Tanyakan kepada pasien apakah mereka memiliki pertanyaan atau komentar.
- b. Minta pasien untuk mengonfirmasi atau memperjelas informasi yang diberikan.

5. Pemantauan Keamanan Pasien

- a. Pastikan bel panggilan pasien mudah dijangkau.
- b. Periksa bahwa peralatan seperti hisap dan oksigen berfungsi dengan baik dan mudah diakses.
- c. Pastikan pembalut, saluran pembuangan, cairan infus, dan pompa infus dalam kondisi aman dan benar.
- d. Jaga kerapian umum area, agar kondusif untuk keamanan.
- e. Perhatikan mobilitas dan kemudahan akses pasien.
- f. Lakukan pemeriksaan lain yang mungkin diperlukan untuk pasien tersebut, seperti penggunaan rel tempat tidur atau ketinggian tempat tidur.

R. Dokumentasi Dalam timbang terima

Komunikasi dalam bidang keperawatan memiliki fungsi krusial dalam memperkuat pengakuan terhadap perawatan yang diberikan, menjadi jembatan antara anggota tim kesehatan, dan bertindak sebagai catatan pasien selama proses perawatan. Kemampuan untuk mendokumentasikan dengan baik membantu

perawat dalam berbagi informasi dengan tenaga medis lainnya serta menjelaskan berbagai tindakan yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung, atau yang masih akan dilakukan. Ini sangat penting untuk dicatat selama proses serah terima, mencakup hal-hal berikut:

1. Informasi identitas pasien.
2. Diagnosis medis pasien.
3. Dokter yang menangani pasien ini.
4. Kondisi umum pasien saat ini.
5. Isu keperawatan yang sedang dihadapi.
6. Intervensi yang telah dilakukan dan yang masih diperlukan.
7. Tindakan kolaborasi yang telah dilaksanakan.
8. Rencana umum dan persiapan lain yang berkaitan.
9. Tandatangan dan nama yang jelas..

S. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Merencanakan perawatan pasien secara individu. Konferensi ini diharapkan setiap staf memberikan masukan dalam pembahasan asuhan pasien secara individu dan komprehensif, hal ini termasuk dalam konferensi:
 - A. Definisi
 - B. Tujuan
 - C. Pedoman pelaksanaan
 - D. *Pre conference*
 - E. *Post conference*
2. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan serah terima
 - A. 5-10 menit
 - B. 15-20 menit
 - C. 30 menit
 - D. 45 menit
 - E. > 1 jam
3. Hal yang mencakup rincian pasien, alasan singkat mengapa Anda menyerahkan pasien, dan memastikan bahwa Anda menyerahkan kepada orang yang tepat, dan bahwa mereka tahu siapa Anda. Ini bagian dari :
 - A. Situation
 - B. Background
 - C. Assessment
 - D. Rekomendasi
 - E. Semua benar

4. Gunakan terminologi medis dan keperawatan yang relevan. Hindari singkatan atau ambigu. Jika Anda akan melakukan serah terima kepada staf lulusan baru atau staf junior, jelaskan anomali apa pun pada perawatan atau pengobatan pasien yang mungkin tidak mereka kenal. Hal ini termasuk dalam teknik timbang terima :
- A. Terorganisir
 - B. Tetap fokus
 - C. Berkomunikasi dengan jelas
 - D. Berpusatkan pada pasien
 - E. Berikan waktu
5. Persyaratan dalam pelaksanaan *Pre* dan *Post Conference* adalah:
- A. Tujuan yang telah ditetapkan dalam konferensi sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu.
 - B. Diskusi yang berlangsung harus mencerminkan prinsip-prinsip kelompok yang dinamis.
 - C. Instruktur klinis berperan penting dalam menjaga kesinambungan diskusi dengan tetap fokus pada topik yang dibahas, tanpa mendominasi, serta memberikan umpan balik yang diperlukan dengan tepat.
 - D. Instruktur klinis perlu menekankan poin-poin penting selama diskusi berlangsung
 - E. Semua benar

Essay

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi Timbang terima
2. Hal penting apa yang dicatat/didokumentasi dalam proses timbang terima
3. Apa tujuan dari *pre conference*
4. Sebutkan 5 tips Teknik timbang terima
5. Sebutkan jenis timbang terima

T. Kunci Jawaban

1. B
2. B
3. A
4. C
5. E

U. Rangkuman Materi

Pelaksanaan kegiatan pengarahan di ruang perawatan mencakup konferensi dan timbang terima. Dalam konteks keperawatan, konferensi dan timbang terima berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perawat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang terbaru, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi terkini dari pelaksanaan perawatan. Konferensi, di sisi lain, adalah bentuk komunikasi dalam tim. Perawat primer atau Perawat Pelaksana bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaksanaan asuhan keperawatan setelah proses timbang terima, yang juga dikenal sebagai pre konferensi. Sementara itu, post konferensi adalah pertemuan tim yang bertujuan untuk menyampaikan hasil asuhan keperawatan yang telah diberikan, agar dapat ditindaklanjuti pada saat timbang terima oleh perawat yang bertugas pada shift berikutnya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan asuhan keperawatan yang komprehensif. Sedangkan Timbang terima merupakan pertukaran informasi mengenai kondisi pasien yang menggunakan metode SBAR. Proses ini sangat berguna untuk mencegah kesalahan informasi serta memastikan kelanjutan asuhan keperawatan yang berkualitas.

V. Glosarium

SBAR : *Situation Background Assessment Recommendation*

Perawat primer : perawat ketua tim

W. Daftar Pustaka

- Afip Saefulloh, Aria Pranata, Rany Mulyani (2020). Komunikasi pada saat handover memengaruhi pelaksanaan indikator patient safety
- Ardoin, K. B., & Broussard, L. (2011). Implementing Handoff Communication. 27(3). <https://doi.org/10.1097/NND.0b013e318217b3dd>
- Australian Healthcare and Hospitals Association, (2009), Clinical handover: system change, leadership and principle, Australian Healthcare & Hospitals Association
- Australian Nursing and Midwifery Journal, (2020). 5 Tips To A Good Clinical Handover
- Buechel Cat (2024). Handing Over Patients. <https://geekymedics.com/handing-over-patients/>
- Chaboyer, W., McMurray, A., Wallis, M. & Chang, H.Y. (2008) Standard Operating Protocol for Implementing Bedside Handover in Nursing, Griffith University, Australia

- Eka Widiastuti, Wasis Eko Kurniawan, Ikit Netra Wirakhmi (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Perawat terhadap Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) Timbang Terima di RS Hermina Purwokerto).
- Friesen, M. A., White, S. V., & Byers, J. F., (2009), Handoffs: Implications for Nurses, Nurses First, Volume 2, Issue 3 May/June 2009
- Hughes, R. G., (2008), Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services, 540 Gaither Road Rockville, MD 20850
- Mairestika, Setiawan, Rizany (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Timbang Terima
- Maylinda Vebrianti S, Milya Helen, Dwi Rohyani (2024). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Handover Dengan Metode Pendekatan Komunikasi SBAR Di Rumah Sakit X Di Jakarta Pusat.
- NHS : Institute for Innovation and Improvement (2008). Releasing Time to Care. The Productive Community Hospital. Handover. Version 1
- Nursalam. (2014). Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam praktek keperawatan Profesional. Salemba medika.
- Silvia Nur Anggraini, Rizki Yeni Wulandari, Yunina Elasar (2024). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pre Danpost Conference Di Ruang Anak RSUD Pringsewu. <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/majalahcendekiamengabdi>
- Suarli, Bahtiar. (2012). Manajemen keperawatan dengan pendekatan praktis. Erlangga
- Swansburg, R. C. (2012). Pengantar kepemimpinan dan manajemen keperawatan untuk perawat klinis (Terjemahan). EGC.
- Syah Putra, C. (2016). Buku Ajar Manajemen Keperawatan. In Media.
- Washington, N., Brown, L., & Gilmore, J. (2015). Standardizing the OR to PACU patient hand over. AORN, 101, P10–P12. <https://doi.org>

PROFIL PENULIS



Ns. Maryana, M.Kep., Lahir di Sungailiat, 09 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tahun 2010, Pendidikan Profesi Nesrs tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 bergabung di STIKES Citra Delima Bangka Belitung sampai dengan sekarang (Sekarang beralih bentuk menjadi Institut Citra Internasional). Saat ini penulis mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maryana385@yahoo.com

Motto: "Jika Matahari adalah Kesenangan, dan jika Hujan adalah Kesulitan, Maka Kita membutuhkan keduanya untuk melihat PELANGI"



Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM., lahir di Kupang, 13 Mei 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia dengan peminatan Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai Ahli Muda Kesehatan Masyarakat dalam

proyek "Penguatan Kapasitas dan Sinergi Program Pencapaian Universal Access" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2018, penulis bekerja sebagai Pelaksana Teknis Monitoring dan Evaluasi dalam proyek "Pemantapan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan" di kementerian yang sama. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman sebagai surveyor kesehatan ibu dan anak dalam program pengabdian masyarakat di Universitas Diponegoro. Saat ini, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten. Penelitian dan publikasi ilmiah penulis di bidang kesehatan lingkungan dan epidemiologi.

PROFIL PENULIS



Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H., lahir di Balikpapan-Kalimantan timur pada 27 Maret 1982, merupakan lulusan S1 dan profesi Ners dari Program Studi Ilmu keperawatan Universitas Gadjah Mada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Kesehatan masyarakat FK-KMK Universitas Gadjah mada pada tahun 2009. Saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu antara lain Manajemen Keperawatan, Ilmu Dasar

Keperawatan, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam penyusunan modul praktikum dan bahan ajar. Penulis telah menerbitkan beberapa buku ajar dan buku referensi. Penulis aktif pula dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta telah menghasilkan berbagai publikasi di jurnal nasional dan jurnal terakreditasi. Alamat korespondensi/e-mail: asdapaty@gmail.com



Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., Ners., M.Kep., lahir di Lumajang, 11 Februari 1987 adalah staf pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Jember sejak tahun 2017. Penulis menempuh pendidikan S1 dan S2 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 dan saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail: rizekifibriansari@unej.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Sarti Oktarina Purba, S.Kep., M.Kep., Lahir di Pematang Siantar, 03 Oktober 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh S1 Keperawatan pada Program Studi Ners Keperawatan, STIK Sint Carolus tahun 2005-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di STIK Sint Carolus dan lulus tahun 2015-2017. Riwayat pekerjaan di RS PGI Cikini diawali pada tahun 1989 sebagai perawat staf ruang perawatan bedah, sebagai perawat staf di ruang ICU

Dewasa, sebagai kepala ruang perawatan bedah, sebagai wakil kepada bidang perawatan, tim Patient safety, Ketua Komite Keperawatan, staf direksi PPSDM, Tim akreditasi RS, Tim penelitian, kepala bidang keperawatan, penanggung jawab pokja Asesmen pasien, sebagai anggota tim Covid-19, wakil kepala PPSDM. Saat ini penulis sebagai asesor akreditasi rumah sakit. sebagai dosen di STIKes PGI Cikini, sebagai anggota tim perubahan bentuk Akademi menjadi STIKes PGI Cikini, sebagai ketua laboratorium STIKes PGI Cikini, mengampu mata kuliah Kosep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Pelayanan Pastoral, Keperawatan Dasar, Keperawatan Gawat Darurat, Pratik Klinik Keperawatan Dasar. Dan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai staf pengajar, penelitian, publikasi, seminar, pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sartipurba310@gmail.com

Motto: "Meringankan penderitaan adalah karya Ilahi"



Ikawati Setyaningrum, M.Kep., Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Ilmu Keperawatan dan Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi. Lahir di Brebes, 06 November 1986. Penulis menyelesaikan program S1 keperawatan dan Ners di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009 dan menyelesaikan program pasca sarjana (S2) di fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Indonesia tahun 2015. Buku yang pernah ditulis dan terbit berjudul "Teori dan Konsep Keperawatan Pediatrik", "Buku Ajar Ilmu Dasar Keperawatan" serta "Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan". Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.

Buku ajar "Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan" hadir sebagai referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinis, pemimpin, dan manajer dalam memahami prinsip-prinsip dasar hingga aplikasi praktis dalam kepemimpinan dan pengelolaan pelayanan keperawatan. Melalui penyajian materi yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana peran kepemimpinan dan fungsi manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Topik-topik utama dalam buku ini meliputi konsep dan penerapan kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, serta strategi manajemen alur kerja yang esensial, khususnya dalam penanganan pasien COVID-19. Pembaca akan memperoleh panduan praktis tentang bagaimana mengelola alur kerja dengan efisien dan efektif di tengah tantangan pandemi, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan logistik, dan penerapan standar operasional yang ketat.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya adaptasi intrapersonal dan kemampuan mengelola emosi, khususnya dalam mencegah dan menangani burnout di lingkungan kerja yang tinggi tekanan. Fungsi pengarahan dan strategi pengendalian mutu asuhan keperawatan juga dibahas secara komprehensif, dilengkapi dengan panduan praktik terbaik dalam pelaksanaan konferensi klinis dan timbang terima pasien yang sesuai dengan konsep manajemen modern.

Dengan pendekatan yang integratif antara teori dan praktik, buku ini tidak hanya memperkuat kompetensi manajerial tenaga keperawatan, tetapi juga mendorong lahirnya pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang dalam dunia pelayanan kesehatan.

Buku ajar "Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan" hadir sebagai referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinis, pemimpin, dan manajer dalam memahami prinsip-prinsip dasar hingga aplikasi praktis dalam kepemimpinan dan pengelolaan pelayanan keperawatan. Melalui penyajian materi yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana peran kepemimpinan dan fungsi manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Topik-topik utama dalam buku ini meliputi konsep dan penerapan kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, serta strategi manajemen alur kerja yang esensial, khususnya dalam penanganan pasien COVID-19. Pembaca akan memperoleh panduan praktis tentang bagaimana mengelola alur kerja dengan efisien dan efektif di tengah tantangan pandemi, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan logistik, dan penerapan standar operasional yang ketat.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya adaptasi intrapersonal dan kemampuan mengelola emosi, khususnya dalam mencegah dan menangani burnout di lingkungan kerja yang tinggi tekanan. Fungsi pengarahan dan strategi pengendalian mutu asuhan keperawatan juga dibahas secara komprehensif, dilengkapi dengan panduan praktik terbaik dalam pelaksanaan konferensi klinis dan timbang terima pasien yang sesuai dengan konsep manajemen modern.

Dengan pendekatan yang integratif antara teori dan praktik, buku ini tidak hanya memperkuat kompetensi manajerial tenaga keperawatan, tetapi juga mendorong lahirnya pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang dalam dunia pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96049-2-5



9

786349

604925